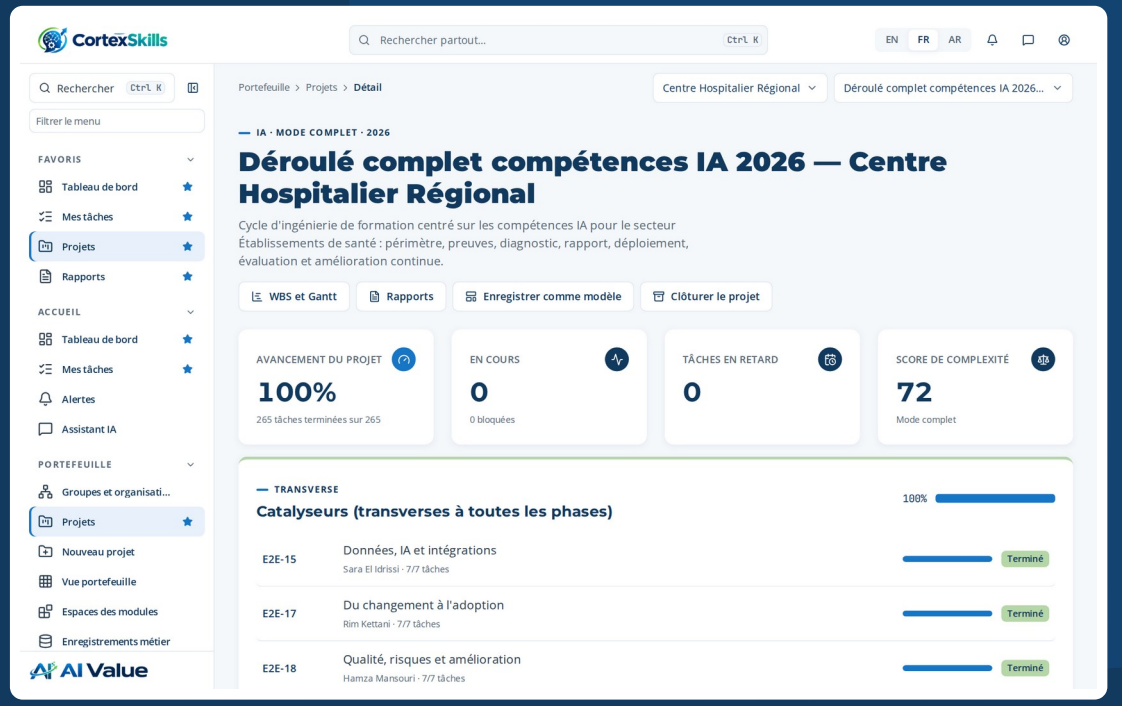
AI Value
Digital & AI Transformation

CAS COMPLET · SANTÉ · 2026

Ingénierie de formation aux compétences IA dans un hôpital public

Centre Hospitalier Régional : le projet, le Rapport d'ingénierie de formation, le Plan de formation et chaque document produit avec CortexSkills



MEASURABLE · GOVERNED · SUSTAINABLE

SOMMAIRE

Déroulé de la présentation

01

L'hôpital et le projet

Contexte, charte, périmètre, méthode, calendrier

02

Diagnostic

Questionnaires, maturité, écarts, besoins

03

Rapport d'ingénierie de formation

Structure, constats, feuille de route, risques

04

Plan de formation

Programmes, déroulés, conception, budget

05

Déploiement, évaluation et audit

Sessions, Kirkpatrick, ROI, audit

06

Documents produits

37 documents publiés, tracés

SYNTHÈSE

Un cycle complet de compétences IA, documenté de bout en bout

Centre Hospitalier Régional · 3 400 collaborateurs · Déroulé complet compétences IA 2026 — Centre Hospitalier Régional

100 %
du déroulé réalisé — 35 processus de bout en bout

37 / 40
personnes ont répondu aux questionnaires (93 %)

6
formations dans 2 programmes, priorisées par impact

1 260 000
budget de formation ; 1 192 662 consommés

Ce que montre le cas

- Diagnostic : « Systèmes d'information » est l'axe le plus faible (2 / 5) ; le plus grand écart est « Planification IA des lits et des effectifs » (écart moyen 3.0).
- 10 besoins de formation ont été validés et regroupés en 6 thèmes, déployés en 4 initiatives sur trois vagues.
- Résultats Kirkpatrick 86 % · 93 % · 84 % ; ROI de la formation 108 % (cible ≥ 100 %).
- 37 documents publiés, 1 105 pages ; le Rapport d'ingénierie de formation compte à lui seul 210 pages.

01

L’hôpital et le projet

Contexte, charte, périmètre, méthode et calendrier

AI Value
Digital & AI Transformation

CONTEXTE

Centre Hospitalier Régional

Centre Hospitalier Régional opère dans le secteur Établissements de santé, à Région, avec 3400 salariés.

Sujet	Contenu
Vision	Devenir la référence du secteur Établissements de santé dans la région, avec des équipes formées aux meilleurs standards.
Mission	Offrir un service sûr et conforme grâce à des équipes compétentes et des processus maîtrisés.
Valeurs	Engagement · Excellence · Partage
Contexte	Concurrence forte, audits ISO 7101 plus stricts et arrivée de Triage IA et aide à la décision clinique.
Produits — existants	Services de base de Soins cliniques et infirmiers
Produits — nouveaux	Services numériques appuyés sur Triage IA et aide à la décision clinique
Segments du marché	Grands comptes · Secteur public · Particuliers

Organigramme et effectif

Fonction	Effectif
Opérations	3
Qualité et HSE	3
Finance	2
Ressources humaines	2
Ventes et marketing	2
Systèmes d'information	2
Soins cliniques et infirmiers	2

Un hôpital public sous pression : pourquoi les compétences d'abord

Ce que disent les SWOT fonctionnels et les objectifs stratégiques

Pression externe

- Audits ISO 7101 plus stricts
- Départ d'experts clés

Opportunités à saisir

- Demande de services numériques
- Contrats de formation remboursés par l'OFPPT
- Planification IA des lits et des effectifs

Points faibles aujourd'hui

- Faible usage de Triage IA et aide à la décision clinique
- Reporting tenu sur des tableurs
- Peu de polyvalence entre les postes
- Faible usage de Planification IA des lits et des effectifs
- Faible usage de Assistance IA en imagerie médicale

Ce à quoi la direction s'engage

- SO-1: Adopter Triage IA et aide à la décision clinique dans Soins cliniques et infirmiers d'ici fin 2027
- SO-2: Zéro écart majeur aux audits ISO 7101

Source : SWOT du RIF 1.4, SWOT fonctionnels (E2E-25) et objectifs stratégiques du périmètre.

Dates clés et SWOT de l'hôpital

2008

Création de l'entreprise

2014

Ouverture du deuxième site

2019

Certification ISO 7101

2025

Lancement du programme de transformation numérique

Forces

- Équipe expérimentée et engagée
- Bonne connaissance du marché
- Processus stables

Axes d'amélioration

- Faible usage de Triage IA et aide à la décision clinique
- Reporting tenu sur des tableurs
- Peu de polyvalence entre les postes
- Faible usage de Planification IA des lits et des effectifs
- Faible usage de Assistance IA en imagerie médicale

Opportunités

- Demande de services numériques
- Contrats de formation remboursés par l'OFPPT

Menaces

- Audits ISO 7101 plus stricts
- Départ d'experts clés

Source : RIF sections 1.3 et 1.4.

Déroulé complet compétences IA 2026 — Centre Hospitalier Régional

Cycle d'ingénierie de formation centré sur les compétences IA pour le secteur Établissements de santé : périmètre, preuves, diagnostic, rapport, déploiement, évaluation et amélioration continue.

72
score de complexité (sur 100) : déroulé complet avec jalons

40
parties prenantes enregistrées et consultées

17
critères de périmètre approuvés

MS · MO · OP
niveaux de décision couverts (stratégique, intermédiaire, opérationnel)

Objectifs stratégiques

- SO-1 — Adopter Triage IA et aide à la décision clinique dans Soins cliniques et infirmiers d'ici fin 2027 (échéance 2027-12-31)
- SO-2 — Zéro écart majeur aux audits ISO 7101 (échéance 2026-12-31)

Fonctions et niveaux de décision couverts

Orientation: AI · Niveaux de décision: MS, MO, OP · Approbation: Approuvé (2026-04-30, Soukaina Ouazzani)

Fonction	MS — stratégique	MO — intermédiaire	OP — opérationnel
Opérations	●	●	●
Qualité et HSE	●	●	—
Finance	●	—	●
Ressources humaines	—	●	●
Ventes et marketing	●	●	●
Systèmes d'information	●	●	—
Soins cliniques et infirmiers	●	—	●

Comment le périmètre est fixé

Chaque case fonction × niveau de décision est un critère pondéré du périmètre. 16 critères ont été approuvés par le sponsor avant l'envoi de tout questionnaire ; chaque tableau du rapport est ensuite filtré par ce périmètre.

Source : RIF section 1.8.

MÉTHODE

Six phases, chacune close par un jalon et ses livrables

La mission d’ingénierie de formation suit les phases ci-dessous, chacune clôturée par un jalon et ses livrables.

Phase	Processus de bout en bout	Avancement
1. Périmètre et collecte de preuves	E2E-32 · E2E-33 · E2E-19 · E2E-24	100%
2. Diagnostic	E2E-20 · E2E-25 · E2E-26 · E2E-27 · E2E-28 · E2E-29 · E2E-02 · E2E-21	100%
3. Rapport d'ingénierie de formation et plan	E2E-01 · E2E-03 · E2E-30 · E2E-22 · E2E-23 · E2E-16 · HCPR-E2E-02	100%
4. Conception et déploiement	E2E-04 · E2E-05 · E2E-06 · E2E-13 · E2E-14	100%
5. Évaluation, conformité et impact	E2E-07 · E2E-08 · E2E-09 · HCPR-E2E-01	100%
6. Talents, savoirs et amélioration continue	E2E-10 · E2E-11 · E2E-12 · E2E-31	100%

Source : Rapport d’ingénierie de formation, section 1.5 « La mission en cours ».

35 processus de bout en bout, 265 tâches, toutes réalisées

Chaque processus a un responsable, ses tâches, ses dates et le document qu'il produit

Phase	Processus	Tâches faites	Début	Fin	Resp.
Catalyseurs (transverses à toutes les phases)	3	21 / 21	2026-04-10	2026-05-01	3
Périmètre et collecte de preuves	4	37 / 37	2026-04-10	2026-05-16	4
Diagnostic	8	62 / 62	2026-05-08	2026-06-07	3
Rapport d'ingénierie de formation et plan	7	50 / 50	2026-06-05	2026-07-05	3
Conception et déploiement	5	39 / 39	2026-07-03	2026-07-30	3
Évaluation, conformité et impact	4	26 / 26	2026-07-31	2026-08-24	2
Talents, savoirs et amélioration continue	4	30 / 30	2026-08-28	2026-09-21	4

265 / 265

tâches réalisées, aucune en retard ni bloquée

14

responsables de processus de l'équipe projet

37

documents publiés, un par processus et plus

Source : espace projet (phases, processus, tâches).

PROCESSUS ET RESPONSABLES

Qui a porté chaque processus du déroulé

E2E	Processus — document produit	Phase	Responsable	Tâches
E2E-15	Gouvernance des données, de l'IA et des intégrations	Catalyseurs (transverses à to…	Sara El Idrissi	7/7
E2E-17	Plan de conduite du changement et d'adoption	Catalyseurs (transverses à to…	Rim Kettani	7/7
E2E-18	Rapport qualité, risques et amélioration	Catalyseurs (transverses à to…	Hamza Mansouri	7/7
E2E-32	Cahier des charges et registre des parties prenantes	Périmètre et collecte de preu…	Leila Chraibi	9/9
E2E-33	Rapport de campagne de questionnaires	Périmètre et collecte de preu…	Asmae Fassi	12/12
E2E-19	Rapport de clôture de mission de conseil	Périmètre et collecte de preu…	Hamza Benjelloun	9/9
E2E-24	Note de veille concurrentielle	Périmètre et collecte de preu…	Omar Benjelloun	7/7
E2E-20	Rapport de diagnostic multi-axes et de maturité	Diagnostic	Hamza Benjelloun	10/10
E2E-25	Architecture des emplois et cartographie des compétences	Diagnostic	Soukaina Ouazzani	8/8
E2E-26	Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)	Diagnostic	Soukaina Ouazzani	8/8
E2E-27	Consolidation des demandes de formation	Diagnostic	Leila Chraibi	7/7
E2E-28	Évaluation des performances et tableau RAG	Diagnostic	Leila Chraibi	7/7
E2E-29	SWOT fonctionnel et axes d'amélioration	Diagnostic	Leila Chraibi	7/7
E2E-02	Diagnostic des écarts de compétences	Diagnostic	Leila Chraibi	7/7
E2E-21	Évaluation de l'impact du plan précédent	Diagnostic	Leila Chraibi	8/8
E2E-01	Plan annuel de formation et budget	Rapport d'ingénierie de forma…	Leila Chraibi	8/8
E2E-03	Rapport des besoins de formation et feuille de route	Rapport d'ingénierie de forma…	Leila Chraibi	10/10

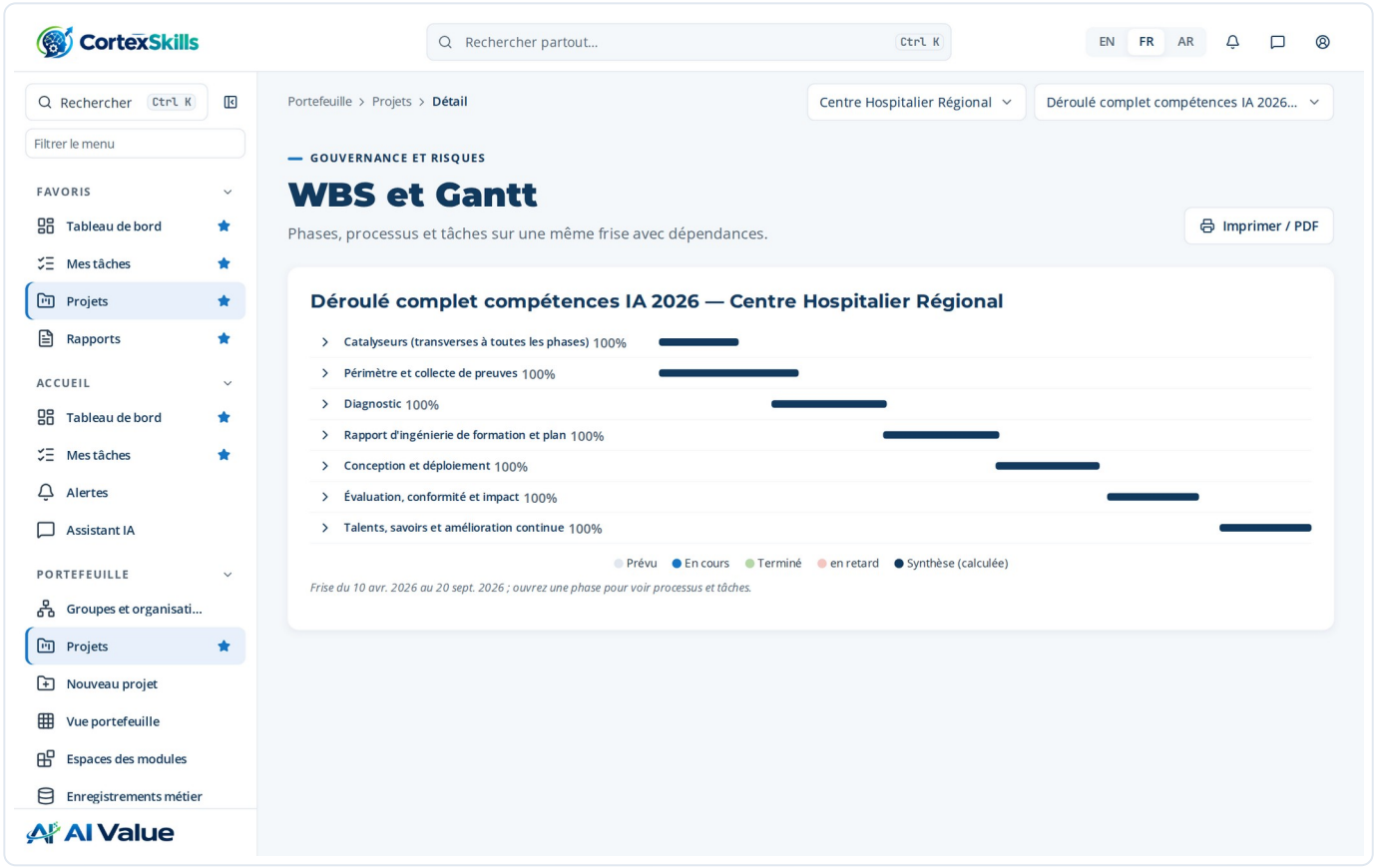
Les processus du déroulé (suite)

E2E	Processus — document produit	Phase	Responsable	Tâches
E2E-22	Plan de déploiement multi-sites	Rapport d'ingénierie de forma…	Leila Chraibi	8/8
E2E-23	Dossier de soumission réglementaire	Rapport d'ingénierie de forma…	Kawtar Rami	7/7
E2E-16	Dossier de gestion des prestataires	Rapport d'ingénierie de forma…	Imane Naciri	6/6
HCPR-E2E-02	Processus propre au secteur santé (alimente le RIF et l'a…	Rapport d'ingénierie de forma…	Leila Chraibi	4/4
E2E-04	Dossier de conception pédagogique	Conception et déploiement	Leila Chraibi	8/8
E2E-05	Rapport de réalisation des formations	Conception et déploiement	Leila Chraibi	9/9
E2E-06	Rapport d'engagement des apprenants	Conception et déploiement	Leila Chraibi	8/8
E2E-13	Catalogue et cycle de vie des contenus	Conception et déploiement	Rim Mansouri	7/7
E2E-14	Rapport de formation de l'entreprise étendue	Conception et déploiement	Hajar Chraibi	7/7
E2E-07	Rapport d'évaluation des formations	Évaluation, conformité et imp…	Leila Chraibi	8/8
E2E-08	Rapport de ROI et d'impact métier	Évaluation, conformité et imp…	Leila Chraibi	7/7
E2E-09	Registre de conformité et des certifications	Évaluation, conformité et imp…	Kawtar Rami	7/7
HCPR-E2E-01	Processus propre au secteur santé (alimente le RIF et l'a…	Évaluation, conformité et imp…	Leila Chraibi	4/4
E2E-10	Mobilité interne et parcours de carrière	Talents, savoirs et améliorat…	Soukaina Ouazzani	8/8
E2E-11	Dossier du programme d'intégration	Talents, savoirs et améliorat…	Hamza Lahlou	7/7
E2E-12	Capitalisation et transfert des connaissances	Talents, savoirs et améliorat…	Omar Alaoui	7/7

Lots de travaux et diagramme de Gantt

Lot	Début	Fin	Avancement
Périmètre et preuves	2026-04-10	2026-05-07	100 %
Diagnostic	2026-05-08	2026-06-04	100 %
Rapport et plan	2026-06-05	2026-07-02	100 %

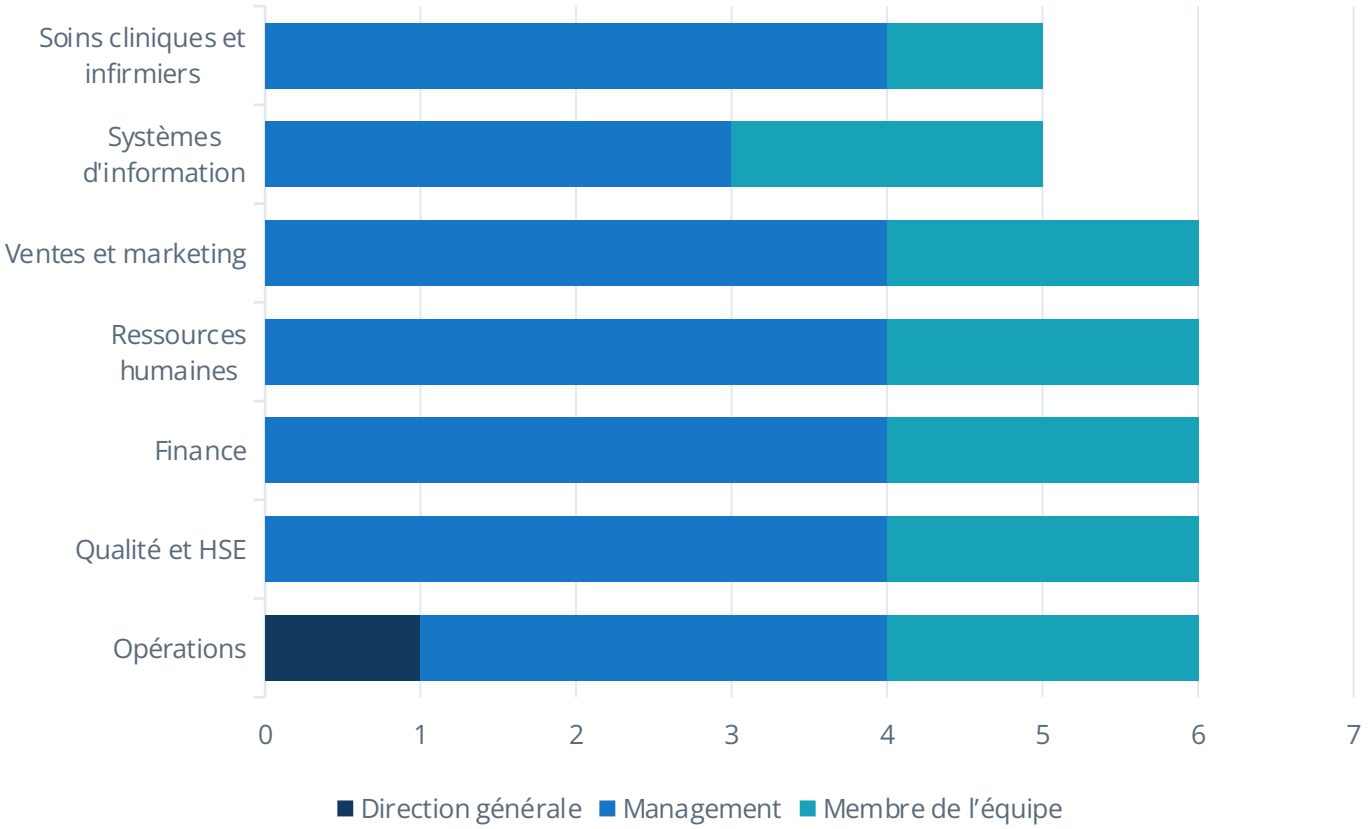
Sessions	Date
S-01 Triage IA et aide à la décision …	2026-07-19
S-02 Assistance IA en imagerie médica…	2026-07-26
S-03 Triage IA et aide à la décision …	2026-08-02
S-04 Assistance IA en imagerie médica…	2026-08-09



WBS et Gantt du projet dans CortexSkills.

40 personnes consultées dans toutes les fonctions

40 personnes ont été consultées : 1 de la direction générale, 26 managers et 13 collaborateurs.



Personnes consultées par fonction et population (RIF 1.7).

Canal	Personnes
Présentiel	1
Combination	26
E-mail	13

Consentement enregistré pour 40 personnes sur 40 avant tout enregistrement de réponse.

02

Diagnostic

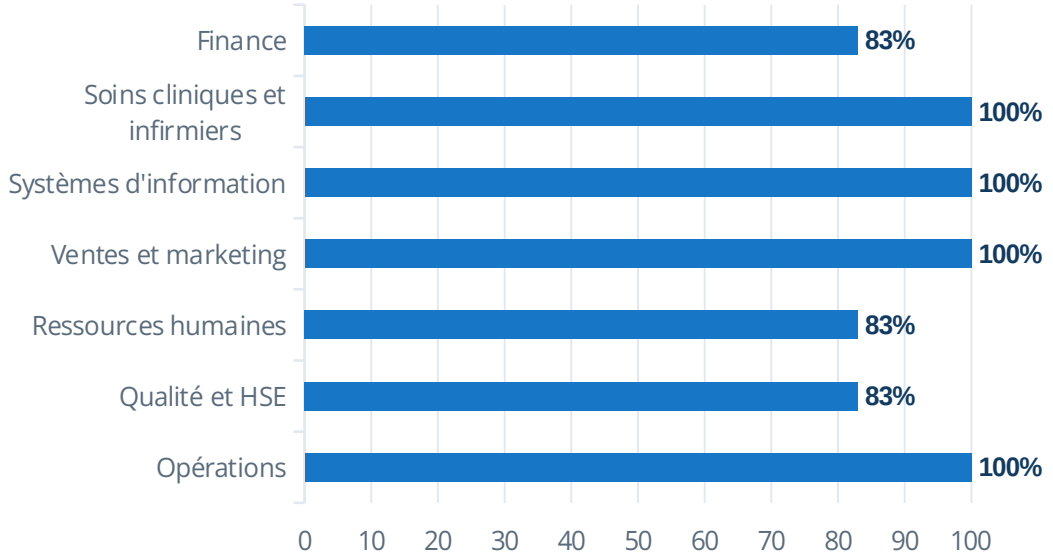
Qui a répondu, où en est l’hôpital, quelles compétences manquent

AI Value
Digital & AI Transformation

37 personnes sur 40 ont répondu

40 personnes ont été invitées à répondre ; 37 ont répondu.

Fonction	Direction générale	Management	Équipe	Répondants
Opérations	1	3	2	6
Qualité et HSE	0	4	2	5
Ressources humaines	0	4	2	5
Ventes et marketing	0	4	2	6
Systèmes d'information	0	3	2	5
Soins cliniques et infirmiers	0	4	1	5
Finance	0	4	2	5



Taux de réponse par fonction.

Canal	Invités	Répondants	Taux	Complétude
Présentiel	12	12	100 %	95 %
Application	23	23	100 %	91 %
E-mail	2	2	100 %	77 %

Source : RIF sections 1.6, 1.12 et 1.13.

Ce que les équipes disent du dernier plan de formation

Qu'avez-vous remarqué à propos du plan de formation de l'année n-1 ?

• Les formations ont été choisies tard dans l'année, avec peu de lien avec nos objectifs.
• Bonne participation, mais peu de suivi après les sessions.

Quels étaient les points forts du plan de formation de l'année n-1 ?

• Des sessions sur site, proches des équipes.
• Des formateurs pratiques qui connaissaient notre secteur.

Quelles étaient les améliorations apportées par le plan de formation de l'année…

• Les encadrants utilisent les nouvelles procédures.
• Moins d'erreurs sur les enregistrements ISO 7101.

Quels étaient les défis concernant le plan de formation de l'année n-1 ?

• Mesurer l'effet des formations.
• Libérer les personnes de leur poste pendant les pics d'activité.

Qu'avez-vous apprécié et aimé à propos du plan de formation de l'année n-1 ?

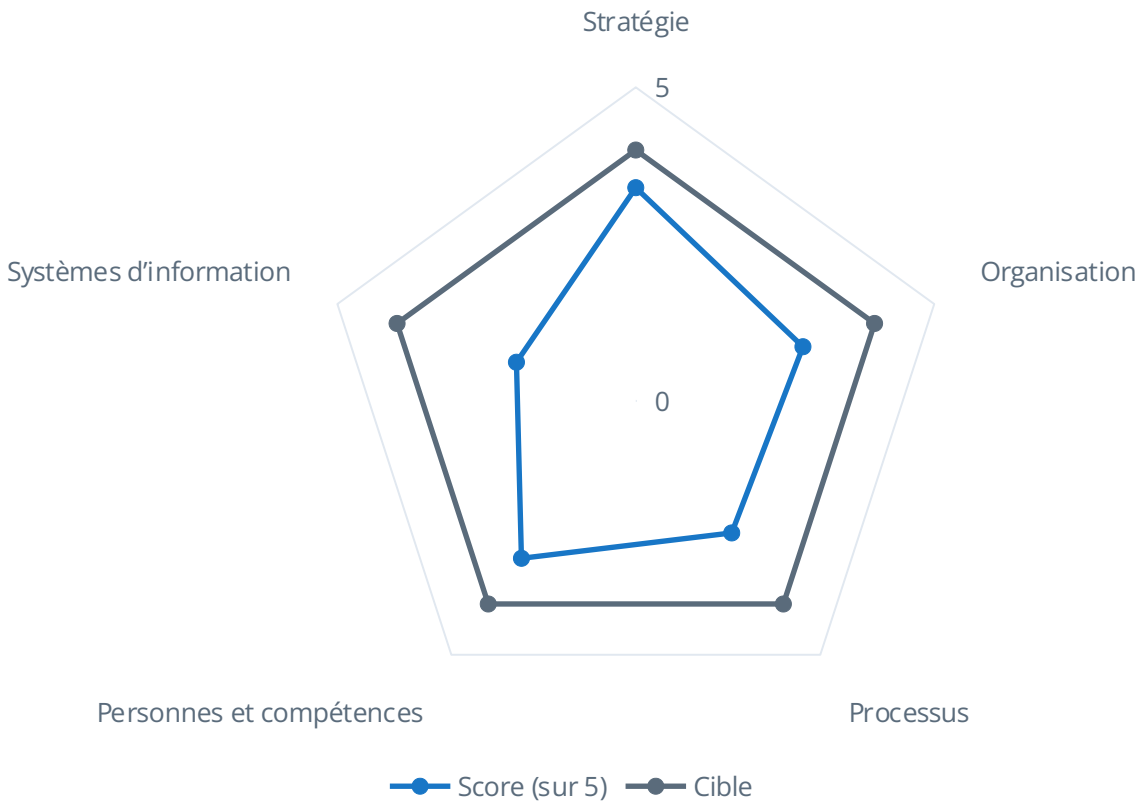
• Les ateliers sur des cas réels.
• Les échanges entre sites.

Si on faisait un nouveau plan de formation, qu'est-ce que vous aimeriez voir de…

• Des formats courts en demi-journée avec un atelier à chaque fois.
• Un plan construit à partir des besoins de chaque fonction.

Source : RIF chapitre 2 — 59 formations suivies sont listées en section 2.1.

Cinq axes évalués, maturité un niveau sous la cible



Score de diagnostic par axe face à la cible de niveau 4 (RIF 1.9).

Axe	Score	Lecture
Stratégie	3.4	Point fort à consolider
Organisation	2.8	Partiellement en place
Processus	2.6	Partiellement en place
Personnes et compétences	3.1	Partiellement en place
Systèmes d'information	2	Priorité de développement

Modèle	Actuel	Cible	Écart
Maturité CMM (CMM)	3	4	1
Maturité du leadership (Leadership)	3	4	1

Modèles de maturité (RIF 1.10).

Où se situe chaque fonction à chaque niveau de décision

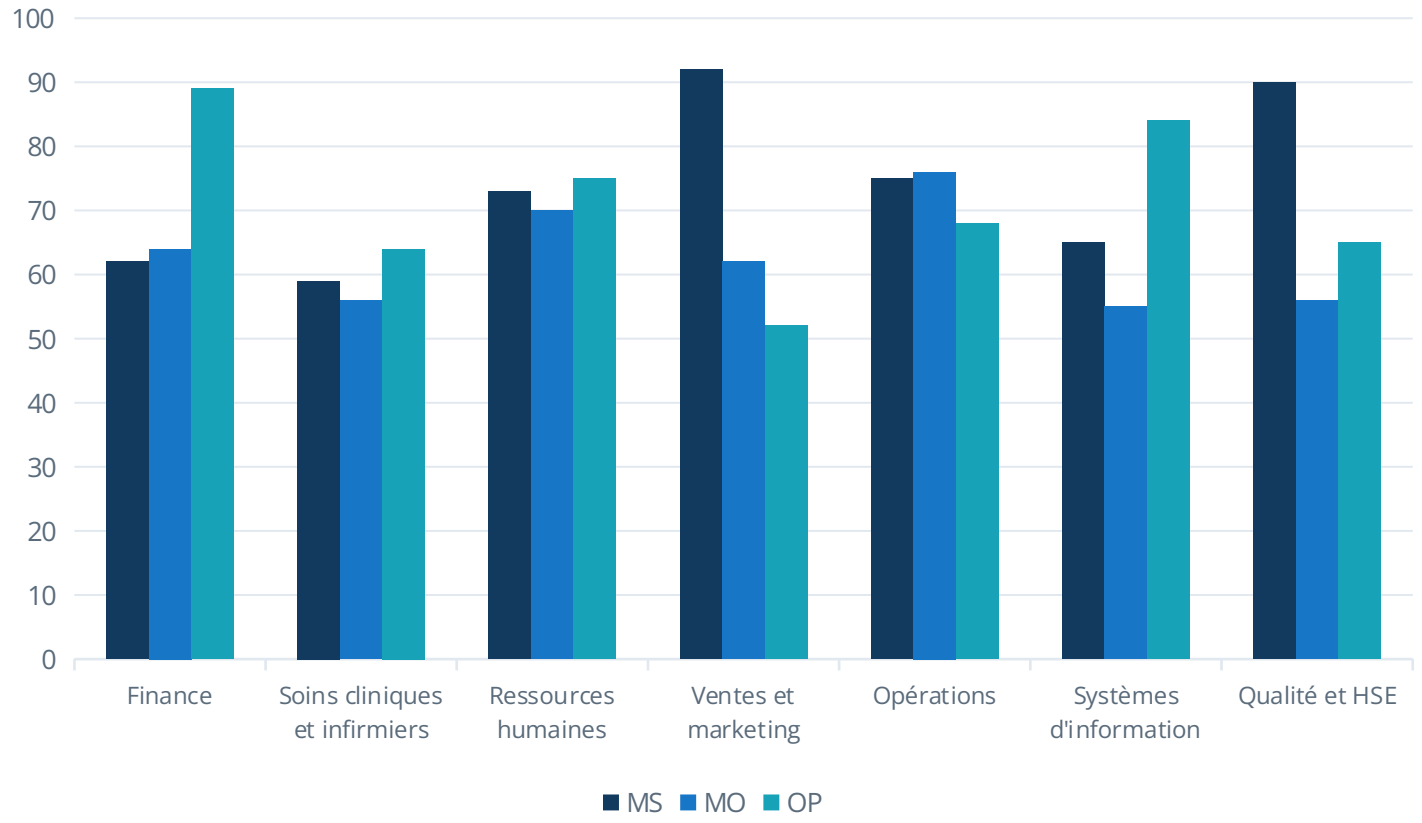
Performance par niveau : MS management stratégique, MO management opérationnel, OP opérationnel.

Fonction	MS	MO	OP	Écarts principaux
Opérations	75% Orange	76% Orange	68% Rouge	Triage IA et aide à la décision clinique · Assistance IA en imagerie médicale · Planification …
Qualité et HSE	90% Vert	56% Rouge	65% Rouge	Assistance IA en imagerie médicale · Planification IA des lits et des effectifs · Triage IA et…
Finance	62% Rouge	64% Rouge	89% Orange	Planification IA des lits et des effectifs · Triage IA et aide à la décision clinique · Assist…
Ressources humaines	73% Orange	70% Orange	75% Orange	Triage IA et aide à la décision clinique · Assistance IA en imagerie médicale · Planification …
Ventes et marketing	92% Vert	62% Rouge	52% Rouge	Assistance IA en imagerie médicale · Planification IA des lits et des effectifs · Triage IA et…
Systèmes d'information	65% Rouge	55% Rouge	84% Orange	Planification IA des lits et des effectifs · Triage IA et aide à la décision clinique · Assist…
Soins cliniques et infirmiers	59% Rouge	56% Rouge	64% Rouge	Triage IA et aide à la décision clinique · Assistance IA en imagerie médicale · Planification …

Carte de chaleur sur l'échelle de statut fixe rouge → vert (RIF 3.2).

21 cases évaluées : fonction × niveau de décision

Score en % de la performance attendue, d'après les enregistrements d'évaluation (E2E-26)



Score de performance par fonction et niveau de décision (%).

Case	%	Écart relevé
Ventes et marketing — OP	52	Triage IA et aide à la décision clinique
Systèmes d'information — MO	55	Triage IA et aide à la décision clinique
Qualité et HSE — MO	56	Planification IA des lits et des effect…
Soins cliniques et infirmiers — MO	56	Assistance IA en imagerie médicale
Soins cliniques et infirmiers — MS	59	Triage IA et aide à la décision clinique
Finance — MS	62	Planification IA des lits et des effect…

Les six cases les plus faibles, avec l'écart relevé.

Forces et faiblesses, fonction par fonction

2 SWOT validés avec les responsables de fonction

Opérations — Validé

Forces

- Équipe expérimentée
- processus stables

Faiblesses

- Faible usage de Triage IA et aide à la décision clinique

Opportunités

- Planification IA des lits et des effectifs

Menaces

- Audits ISO 7101 plus stricts

Qualité et HSE — Validé

Forces

- Équipe expérimentée
- processus stables

Faiblesses

- Faible usage de Triage IA et aide à la décision clinique

Opportunités

- Planification IA des lits et des effectifs

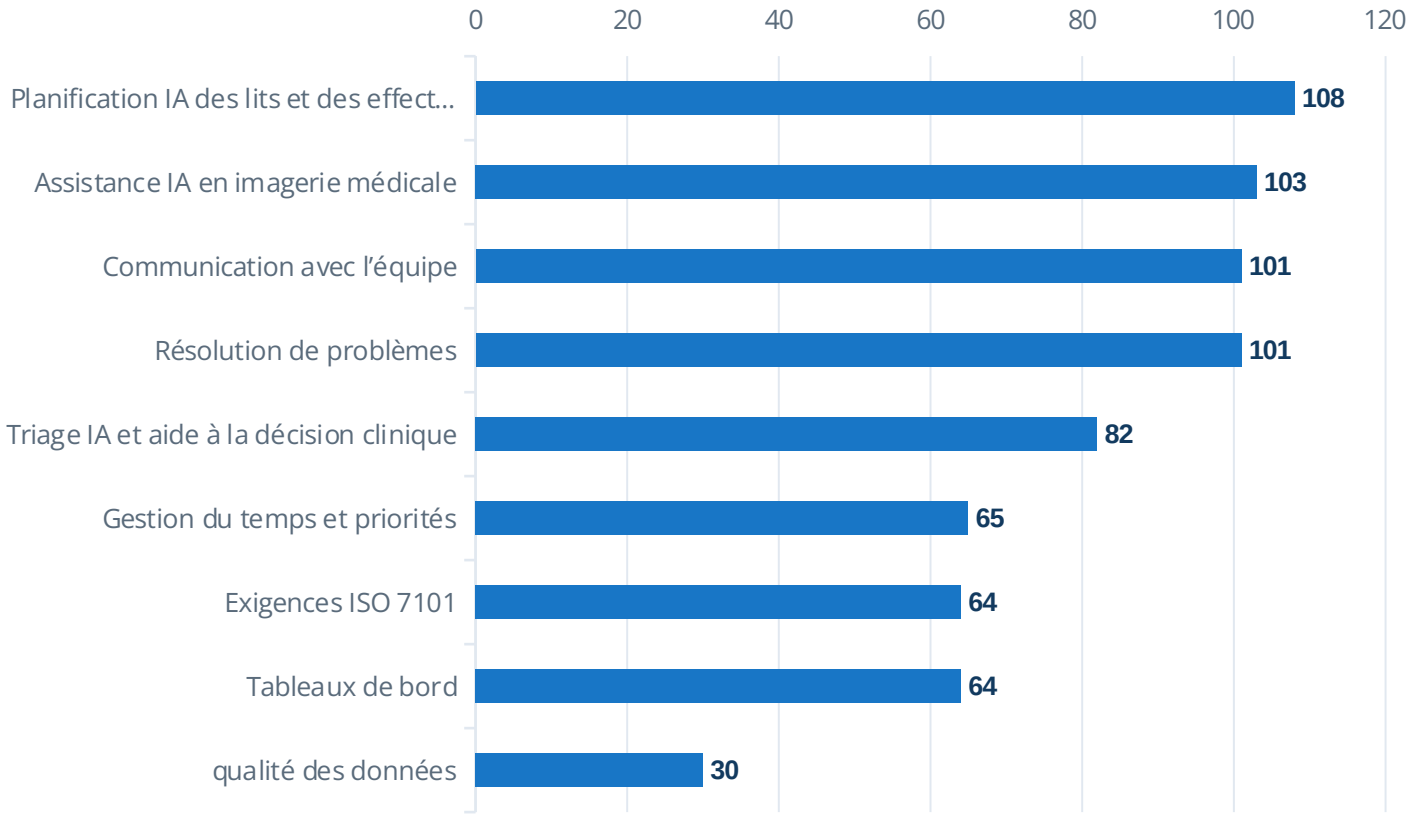
Menaces

- Audits ISO 7101 plus stricts

Source : enregistrements SWOT fonctionnels (E2E-25), à l'origine des axes d'amélioration.

Les compétences demandées, par nombre de mentions

Consolidé à partir de 32 réponses.



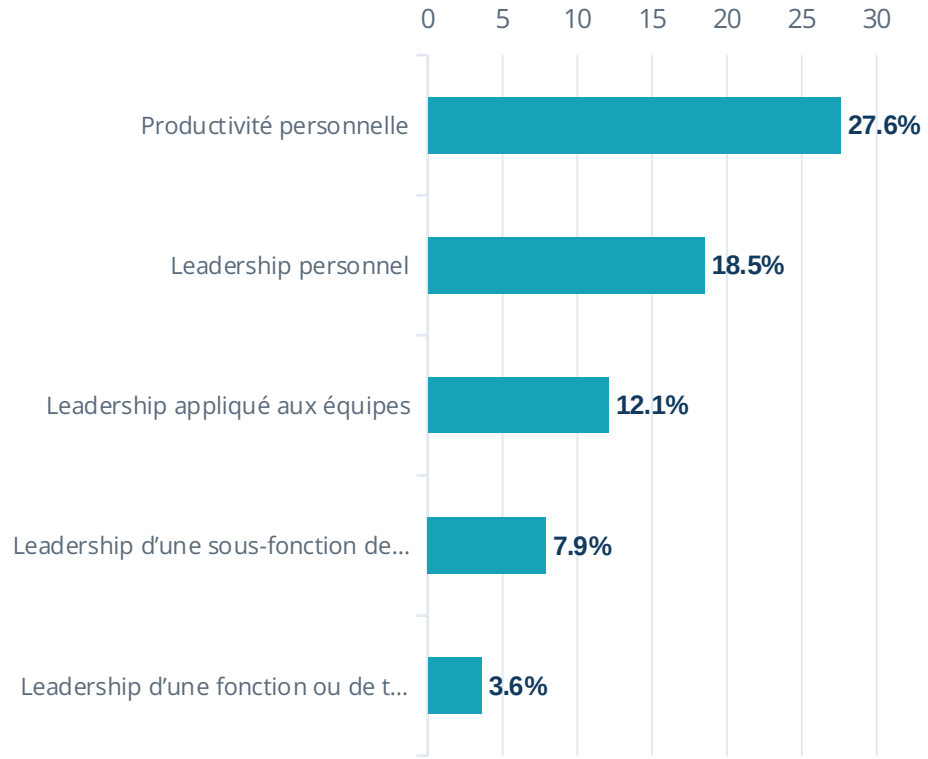
Lecture

Les deux thèmes IA cliniques arrivent en tête (108 et 103 mentions), suivis de la communication d'équipe et de la résolution de problèmes : le plan associe chaque formation IA à des ateliers pratiques sur les cas propres à l'hôpital.

Mentions dans l'ensemble des réponses (RIF 3.3).

Auto-évaluation des répondants, du plus faible au plus fort

Compétence	Moyenne (1–5)	n
Auto-contrôle et excellence	3.2	31
Amélioration continue de la qualité — résolution de conflits et solut…	3.2	29
Accompagnement des autres pour l'excellence	3.3	29
Management par les valeurs	3.3	30
Management d'entreprise : vue macro des métiers / fonctions de l'entr…	3.3	20
Formations et efficacité	3.3	30
Auto-motivation et énergie	3.4	31
Communication avec soi-même	3.4	31

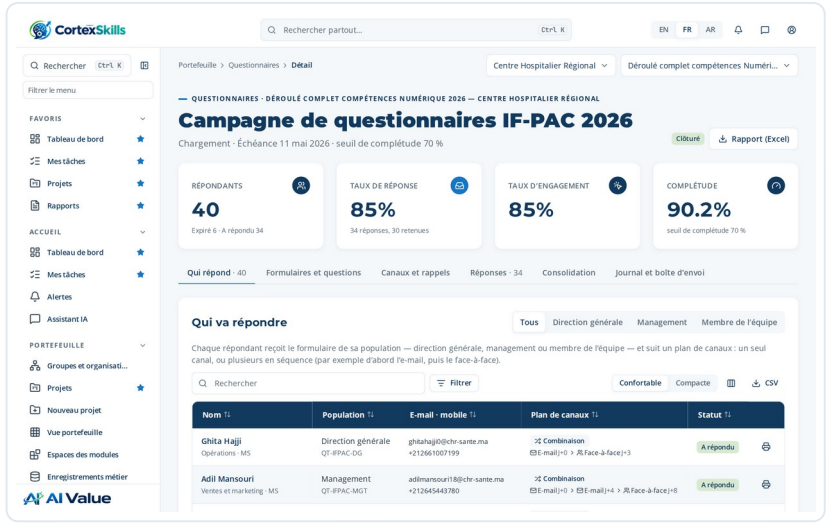


Niveaux de leadership atteints (RIF 3.7).

Des écarts mesurés à un registre de besoins validé

Compétence	Personnes	Écart moyen	Critiques
Assistance IA en imagerie médicale	3	2.0	0
Planification IA des lits et des effectifs	2	3.0	2
Triage IA et aide à la décision clinique	3	1.0	0

Écarts par compétence (RIF 3.40).

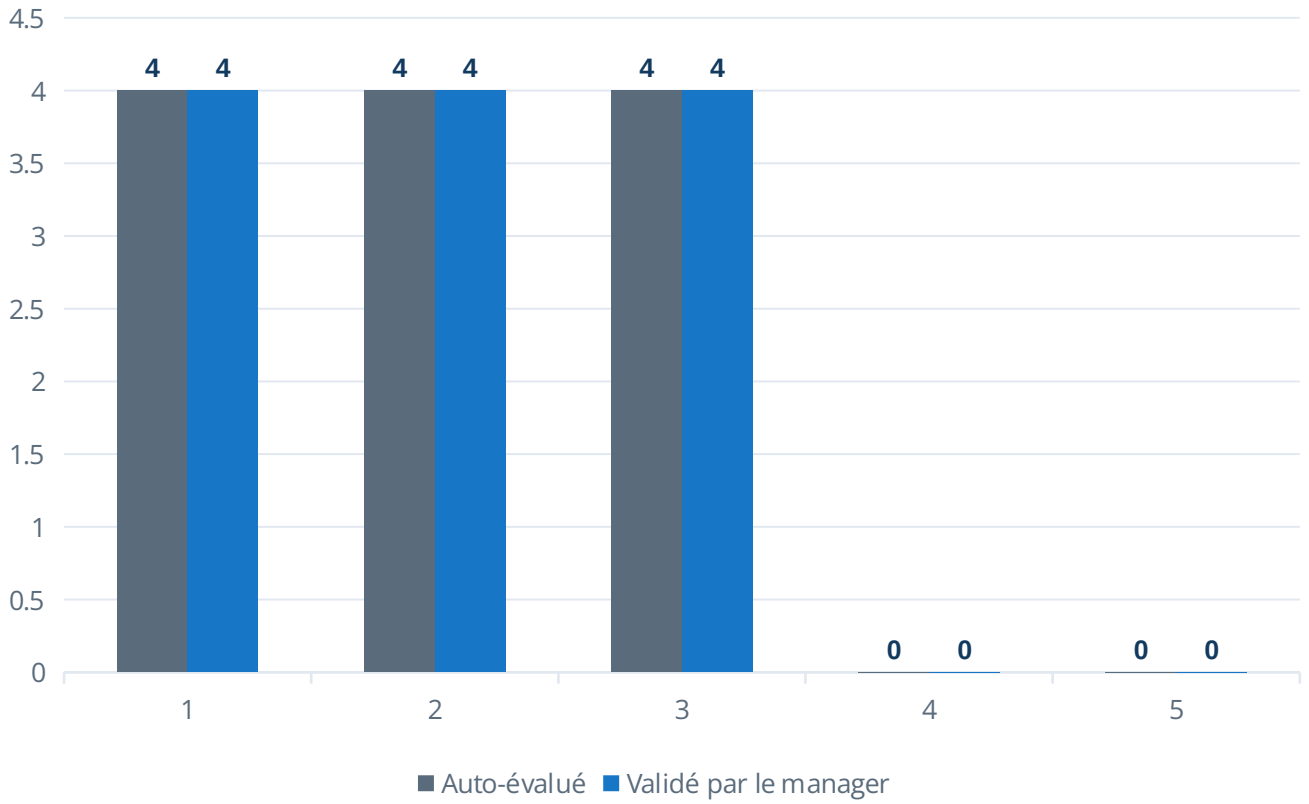


#	Thème	Source	Impact	Statut
1	Planification IA des lits et des effectifs	Diagnostic	5	Validé
2	IA responsable et protection des données	Écart de compétences	5	Validé
3	Planification IA des lits et des effectifs	GPEC	5	Validé
4	Assistance IA en imagerie médicale	Demande	4	Validé
5	Prompting et IA générative au travail	SWOT	4	Validé
6	Assistance IA en imagerie médicale	Diagnostic	4	Validé
7	Triage IA et aide à la décision clinique	Écart de compétences	3	Validé
8	Littératie en IA pour tous	GPEC	3	Validé
9	Triage IA et aide à la décision clinique	Demande	3	Validé
10	Littératie en IA pour tous	SWOT	3	Validé

Registre des besoins (RIF 3.41) : chaque besoin tracé jusqu'à sa source.

Niveaux auto-évalués et validés côte à côte

12 évaluations de la campagne « Campagne de compétences 2026 », close le 2026-05-20



Nombre d'évaluations à chaque niveau.

2.0 → 2.0

niveau moyen, auto-évalué → validé

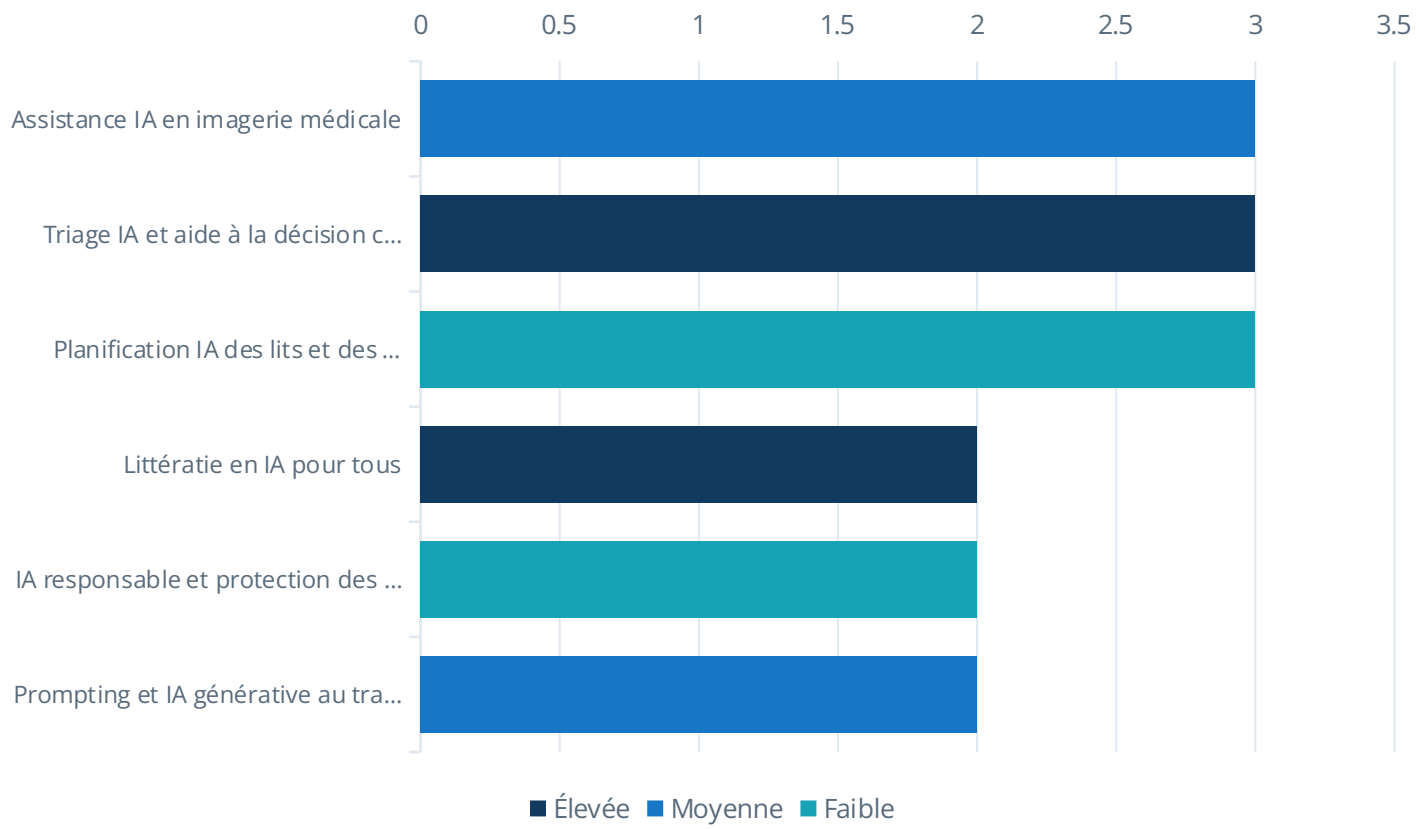
12 · 0 · 0

confirmés · abaissés · relevés par le manager

La validation par le manager transforme une auto-évaluation en écart mesuré : seuls les niveaux validés alimentent les écarts et le registre des besoins.

15 demandes reçues, toutes rattachées à un thème

Demandes individuelles et collectives des managers et des agents (E2E-27)



Statut	Demandes
Planifiée	4
Validé	7
Rejetée	4

Type	Demandes
Individuelle	11
Collective	4

Demandes par thème et priorité.

Soins cliniques et infirmiers

Besoins, évaluation et compétences de la fonction qui porte l'objectif stratégique SO-1

Niveau de décision	Note (%)	Statut	Écart
MS	59 %	Rouge	Triage IA et aide à la décision clinique
MO	56 %	Rouge	Assistance IA en imagerie médicale
OP	64 %	Rouge	Planification IA des lits et des effectifs

Répondant	Population	Forces / Points d'amélioration	Compétences
Reda Naciri	Management	Soins cliniques et infirmiers — Bonne connaissance du marché — Peu de…	Planification IA des lits et des effectifs
Reda Naciri	Management	Soins cliniques et infirmiers — Bonne connaissance du marché — Report…	Planification IA des lits et des effectifs ; Gestion du temps et prio…
Zineb Hajji	Membre de l'équipe	Équipe expérimentée et engagée — Faible usage de Assistance IA en ima…	Assistance IA en imagerie médicale
Zineb Hajji	Membre de l'équipe	Processus stables — Faible usage de Assistance IA en imagerie médicale	Exigences ISO 7101 ; Tableaux de bord
Ayoub Benjelloun	Management	Soins cliniques et infirmiers — Processus stables — Peu de polyvalenc…	Planification IA des lits et des effectifs
Ayoub Benjelloun	Management	Soins cliniques et infirmiers — Bonne connaissance du marché — Report…	Exigences ISO 7101 ; Tableaux de bord

Source : RIF sections 3.36 à 3.39.

Comment les équipes utilisent l'IA et ce qui les freine

Usage actuel

Chaque jour, pour le tri et les rapports. (33)

Freins

Manque de formation et règles peu claires. (33)

Risques à maîtriser

Protection des données et validation des résultats. (33)

Priorités

Planification IA des lits et des effectifs ; qualité des données (12)

Assistance IA en imagerie médicale ; qualité des données (11)

Format préféré

Des ateliers courts sur le poste, puis du coaching. (33)

Pratique de planification stratégique	Oui	Non
Existe-t-il un plan stratégique et des macro business plans au niveau de l'entreprise ?	1	0
Ce plan stratégique et les macro business plans sont-ils mis en place ?	1	0
Sont-ils surveillés ?	0	1
Sont-ils sujets à l'amélioration continue ?	0	1

Réponses les plus fréquentes des 37 répondants (RIF 3.45, 3.46).

Ce que les répondants attendent de la formation

Objectif	Formulation SMART	Mentions
Améliorer la satisfaction des clients	Score de satisfaction ≥ 85 % d'ici la fin de l'année	30
Réduire les coûts de non-qualité	-20 % de reprises en 12 mois	30
Développer le capital humain	80 % des rôles critiques certifiés	14

Résultats attendus

• Des équipes capables d'utiliser Triage IA et aide à la décision clinique en sécurité.

• De meilleurs résultats d'audit et une meilleure fidélisation du personnel.

• Moins d'erreurs et un service plus rapide.

• Des équipes capables d'utiliser Assistance IA en imagerie médicale en sécurité.

Source : RIF 3.42 (74 objectifs exprimés) et 3.9.

03

Rapport d’ingénierie de formation

134 sections, 210 pages, générées à partir des données du déroulé

AI Value
Digital & AI Transformation

Rapport d’ingénierie de formation et plan de formation

Version 1 · auteur Leila Chraibi · approuvé par Soukaina Ouazzani

Chapitre	Sections
1. Description de l’entreprise	14
2. Le plan de formation précédent	2
3. Les besoins en compétences	50
4. Perspectives	3
5. Le plan de formation priorisé	23
6. Risques, contrôles et indicateurs	2
7. Annexes — formulaires d’entretien	38

Plus l’identification, les sources de données et l’approbation.



Le rapport dans l’éditeur de documents.

Besoins liés à la stratégie et aux orientations RH

Axes prioritaires cités par la direction générale: Leadership et performance · Triage IA et aide à la décision clinique · Conformité ISO 7101 · Tableaux de bord

ID	Objectif	Échéance
SO-1	Adopter Triage IA et aide à la décision clinique dans Soins cliniques et infirmiers d'ici fin 2027	2027-12-31
SO-2	Zéro écart majeur aux audits ISO 7101	2026-12-31

Orientations RH

• Mettre à jour les fiches de poste, les objectifs individuels et l'évaluation annuelle ; construire les chemins de carrière.

Gestion du changement

1) Concentration et priorisation · 2) Être optimiste et positif · 3) Être persévérant et assurer le suivi par de courtes répétitions quotidiennes · Patience · Donner l'exemple · Progressivité.

Source : RIF sections 3.1, 3.5 et 3.6.

Quatre initiatives déployées en trois vagues

Les perspectives tiennent compte des orientations stratégiques, du SWOT et des axes d’amélioration, des orientations GRH et des recommandations exprimées lors des rencon…

Vague 1

• Triage IA et aide à la décision clinique — impact 5
• Littératie en IA pour tous — impact 5

Vague 2

• Assistance IA en imagerie médicale — impact 4

Vague 3

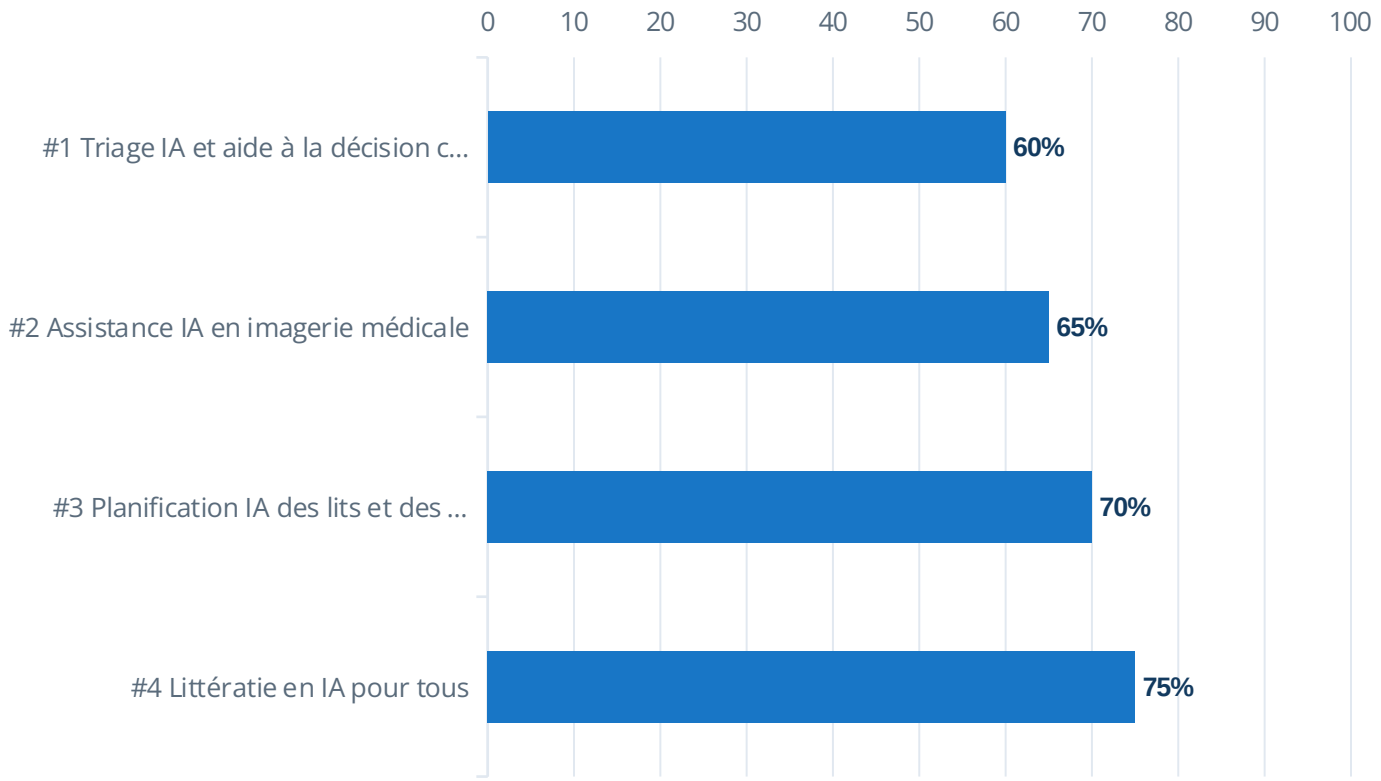
• Planification IA des lits et des effectifs — impact 3

#	Axe d’amélioration	Réalisé	Vague
1	Triage IA et aide à la décision clinique	60%	1
2	Assistance IA en imagerie médicale	65%	2
3	Planification IA des lits et des effectifs	70%	3
4	Littératie en IA pour tous	75%	1

Source : RIF chapitre 4 et section 4.1.

Chaque axe classé, avec son avancement

Axes d'amélioration issus des SWOT et suivis dans la feuille de route



Initiative de la feuille de route	Vague
Triage IA et aide à la décision clinique	1
Littératie en IA pour tous	1
Assistance IA en imagerie médicale	2
Planification IA des lits et des effectifs	3

Avancement moyen 68 % : les axes de la vague 1 sont déployés, les autres sont portés par les vagues 2 et 3.

Avancement de chaque axe d'amélioration, par rang de priorité.

Chaque risque réduit par des contrôles nommés

ID	Risque ou opportunité	Catégorie	Inhérent	Résiduel	Contrôles
RISK-014	Faible adoption par les apprenants et utilisateurs	Adoption	16	8	CTRL-081
RISK-017	Savoirs critiques perdus au départ d'un expert	Opérationnel	16	8	CTRL-070; CTRL-082
RISK-001	Accès non autorisé aux données du locataire	Sécurité	20	6	CTRL-001; CTRL-002; CTRL-048; CTRL-011
RISK-005	Plan de formation non aligné sur la stratégie	Stratégique	16	6	CTRL-049; CTRL-057; CTRL-076
RISK-006	Données de compétences inexactes conduisant à de mauvais besoins	Qualité des données	15	6	CTRL-064; CTRL-045
RISK-030	Les fiches de poste s'écartent de la réalité	Organisationnel	12	6	CTRL-066
RISK-007	Contenu IA non vérifié dans le rapport d'ingénierie de formation	AI	16	5	CTRL-041; CTRL-056
RISK-009	Certification obligatoire expirée	Conformité	20	5	CTRL-053; CTRL-054
RISK-031	Le déploiement d'un site s'écarte du plan groupe	Opérationnel	12	5	CTRL-071

9 premiers risques sur 35 par score résiduel (RIF chapitre 6).

Indicateurs suivis chaque mois pendant le déroulé

ID	Indicateur	Cible	Dernière valeur	Statut
KPI-003	Taux d'écarts critiques	≤ 10 %	2026-10: 8.2	Vert
KPI-004	Délai de production du rapport d'ingénierie de formation	≤ 30 jours	2026-10: 24.6	Vert
KPI-005	Délai d'approbation de la conception	≤ 20 jours	2026-10: 16.4	Vert
KPI-007	Délai de publication des contenus	≤ 15 jours	2026-10: 12.3	Vert
KPI-008	Taux de remplissage des sessions	≥ 85 %	2026-10: 91.8	Vert
KPI-009	Taux de réalisation du plan	≥ 90 %	2026-10: 97.2	Vert
KPI-010	Taux d'achèvement des apprenants	≥ 80 %	2026-10: 86.4	Vert
KPI-012	Satisfaction moyenne de niveau 1	≥ 4,2	2026-10: 4.5	Vert
KPI-013	Taux de progression des compétences	≥ 70 %	2026-10: 75.6	Vert
KPI-015	Taux de correction des dossiers de formation	≤ 1 %	2026-10: 0.82	Vert

10 des 61 indicateurs de la section 6.1 du RIF.

04

Plan de formation

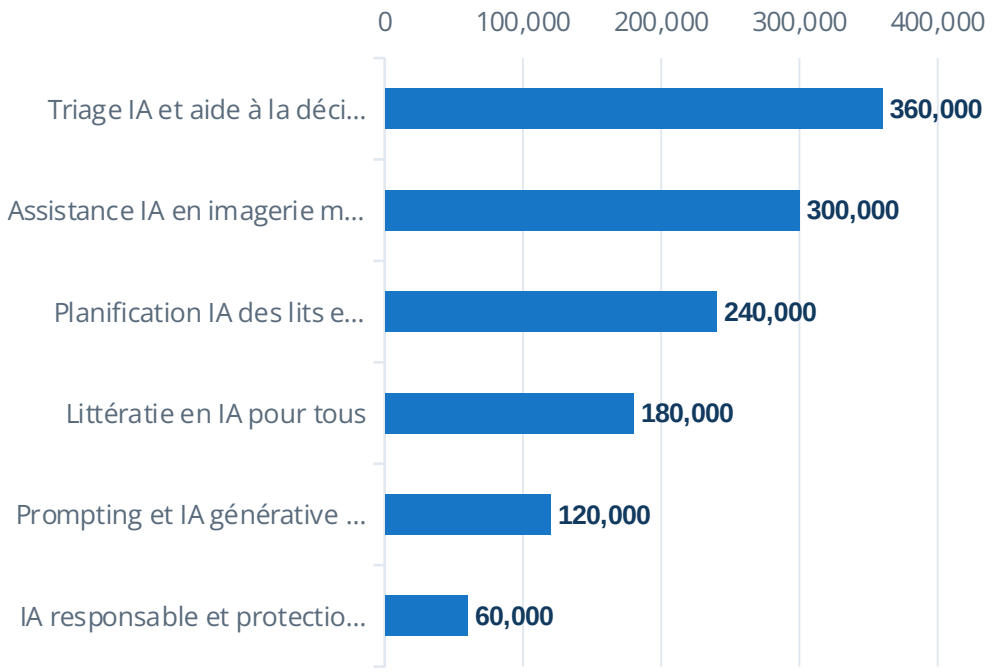
Le plan 2026 comprend 2 programmes et 6 formations, soit 12 jours par groupe au total et 44 journées-groupes à réaliser, pour un budget de ...

AI Value
Digital & AI Transformation

Six thèmes classés par impact et urgence

Plan 2026 — statut Verrouillé — budget 1 260 000.

#	Thème	Jours	Groupes	Budget
1	Triage IA et aide à la décision clinique	3	6	360 000
2	Assistance IA en imagerie médicale	2	4	300 000
3	Planification IA des lits et des effectifs	2.5	3	240 000
4	Littératie en IA pour tous	1.5	3	180 000
5	Prompting et IA générative au travail	1	2	120 000
6	IA responsable et protection des données	2	2	60 000



Budget par thème.

Deux programmes, six formations, des prérequis clairs

Code	Programme	Axe stratégique	Formations
PRG-1	Compétences IA pour Soins cliniques et infirmiers	Exécution de la fonction cœur	TR-AI-01, TR-AI-02, TR-AI-03
PRG-2	Fondamentaux IA pour tous	Leadership, performance et usage responsable	TR-AI-04, TR-AI-05, TR-AI-06

ID	Formation	Niveau	Durée	Prérequis
TR-AI-01	Triage IA et aide à la décision clinique	Intermédiaire	3 jour(s)	Culture numérique de base ; la formation Fondamentaux est recommandée
TR-AI-02	Assistance IA en imagerie médicale	Intermédiaire	2 jour(s)	Culture numérique de base ; la formation Fondamentaux est recommandée
TR-AI-03	Planification IA des lits et des effectifs	Avancé	2.5 jour(s)	TR-AI-01 ou expérience équivalente
TR-AI-04	Littératie en IA pour tous	Fondamentaux	1.5 jour(s)	Aucun — ouvert à tous
TR-AI-05	Prompting et IA générative au travail	Fondamentaux	1 jour(s)	Aucun — ouvert à tous
TR-AI-06	IA responsable et protection des données	Intermédiaire	2 jour(s)	Culture numérique de base ; la formation Fondamentaux est recommandée

Source : Plan de formation « Programmes » et RIF section 5.1.

FICHE DE FORMATION

TR-AI-01 — Triage IA et aide à la décision clinique

Niveau Intermédiaire · 3 jour(s) · programme PRG-1

Objectifs pédagogiques

• Expliquer les concepts clés de Triage IA et aide à la décision clinique et leur application à Soins cliniques et infirmiers
• Appliquer les méthodes et outils de Triage IA et aide à la décision clinique à un cas réel de Centre Hospitalier Régional
• Planifier le déploiement de Triage IA et aide à la décision clinique avec ses indicateurs et contrôles (ISO 7101)

Prérequis

Culture numérique de base ; la formation Fondamentaux est recommandée

Modalités

M1 Triage IA et aide à la décision clinique · E-learning · 2 h
M3 Triage IA et aide à la décision clinique · Classe virtuelle · 3.5 h

Triage IA et aide à la décision clinique — demi-journée par demi-journée

22 activités sur 3 jour(s) : exposés, quiz et ateliers sur les cas propres à l'hôpital.

Jour 1 — matin

Lecture · Fondamentaux de Triage IA et aide à la décision clinique : co… (75 min)
Lecture · Pourquoi Triage IA et aide à la décision clinique compte pour… (45 min)
Quiz — concepts clés de Triage IA et aide à la décision clini… (20 min)
Workshop · Atelier — cartographier les pratiques actuelles de Soins clin… (75 min)

Jour 1 — après-midi

Lecture · Méthodes et outils de Triage IA et aide à la décision clinique (75 min)
Lecture · Exemple commenté du secteur Établissements de santé (40 min)
Quiz — choisir la bonne méthode (20 min)
Workshop · Atelier — appliquer la méthode à un cas réel de Centre Hospit… (80 min)

Jour 2 — matin

Lecture · Gouvernance, risques et exigences ISO 7101 (60 min)
Lecture · Données, qualité et preuves à conserver (45 min)
Quiz — scénarios de conformité et de risque (20 min)
Workshop · Atelier — construire la check-list de contrôle de votre proce… (80 min)

Jour 2 — après-midi

Lecture · Déployer Triage IA et aide à la décision clinique : rôles, ch… (60 min)
Lecture · Indicateurs pour mesurer les résultats (45 min)
Quiz — cas d'adoption et d'indicateurs (20 min)
Workshop · Atelier — concevoir le tableau de bord d'indicateurs de votre… (80 min)

Jour 3 — matin

Lecture · Pratiques avancées et retours d'expérience en Soins cliniques… (75 min)
Quiz — cas avancés (25 min)
Workshop · Atelier — résoudre un scénario d'incident critique (100 min)

Jour 3 — après-midi

Lecture · Transfert en situation de travail : le plan 30-60-90 jours (60 min)
Quiz · Évaluation finale (niveau 2 de Kirkpatrick) (30 min)
Workshop · Atelier — plan d'action individuel et revue entre pairs (90 min)

Pourquoi chaque public doit suivre la formation

Formation TR-AI-01 — comportements, irritants et attentes de chaque persona

Sponsor exécutif — Directeur général

Décide sur des faits présentés en comités courts ; délègue l'exécution à l'équipe de management ; suit quelques indicateurs.

Dépenses de formation sans lien visible avec les objectifs stratégiques ; résultats du plan précédent difficiles à prouver ; audits ISO 7101 qui révèlent des écarts de compétences.

Un plan priorisé au service de la stratégie, un retour mesurable, et une équipe de management capable de conduire le changement.

Manager — directeur, responsable, pilote de processus

Arbitre entre opérations quotidiennes et projets d'amélioration ; préfère des formats pratiques et courts ; s'appuie sur des personnes clés de l'équipe.

Équipe absente du poste pendant des formations longues ; écarts de compétences sur les activités critiques de Soins cliniques et infirmiers ; processus non documentés ou sans pilote.

Des formations qui règlent les vrais problèmes de la fonction, appliquées dès la semaine suivante, avec des indicateurs que le manager peut suivre.

Membre de l'équipe — Soins cliniques et infirmiers

Apprend en faisant et auprès des pairs ; utilise plus le téléphone que l'ordinateur ; veut savoir ce qui change au quotidien.

Nouveaux outils introduits sans explication ; formations théoriques éloignées des tâches ; peur de se tromper avec Triage IA et aide à la décision clinique.

Des compétences pratiques reconnues par une attestation, moins de reprises, et un parcours clair vers le poste suivant.

FICHE DE FORMATION

TR-AI-02 — Assistance IA en imagerie médicale

Niveau Intermédiaire · 2 jour(s) · programme PRG-1 · 4 demi-journées, 15 activités, 14 h

Objectifs pédagogiques

• Expliquer les concepts clés de Assistance IA en imagerie médicale et leur application à Soins cliniques et infirmiers
• Appliquer les méthodes et outils de Assistance IA en imagerie médicale à un cas réel de Centre Hospitalier Régional
• Planifier le déploiement de Assistance IA en imagerie médicale avec ses indicateurs et contrôles (ISO 7101)

Prérequis et types d'activités

Culture numérique de base ; la formation Fondamentaux est recommandée
Lecture: 7 · Quiz: 4 · Workshop: 4

Déroulé par demi-journée

Demi-journée	Activités	min
Jour 1 — matin	Fondamentaux de Assistance IA en imagerie médicale : concepts clés et vocabulaire · Pourquoi Assistance IA en imagerie …	215
Jour 1 — après-midi	Méthodes et outils de Assistance IA en imagerie médicale · Exemple commenté du secteur Établissements de santé · Quiz —…	215
Jour 2 — matin	Gouvernance, risques et exigences ISO 7101 · Données, qualité et preuves à conserver · Quiz — scénarios de conformité e…	205
Jour 2 — après-midi	Transfert en situation de travail : le plan 30-60-90 jours · Évaluation finale (niveau 2 de Kirkpatrick) · Atelier — pl…	180

Personas : Sponsor exécutif — Directeur général · Manager — directeur, responsable, pilote de processus · Membre de l'équipe — Soins cliniques et infirmiers

FICHE DE FORMATION

TR-AI-03 — Planification IA des lits et des effectifs

Niveau Avancé · 2.5 jour(s) · programme PRG-1 · 5 demi-journées, 19 activités, 17 h

Objectifs pédagogiques

• Expliquer les concepts clés de Planification IA des lits et des effectifs et leur application à Soins cliniques et infirmiers
• Appliquer les méthodes et outils de Planification IA des lits et des effectifs à un cas réel de Centre Hospitalier Régional
• Planifier le déploiement de Planification IA des lits et des effectifs avec ses indicateurs et contrôles (ISO 7101)

Prérequis et types d'activités

TR-AI-01 ou expérience équivalente
Lecture: 9 · Quiz: 5 · Workshop: 5

Déroulé par demi-journée

Demi-journée	Activités	min
Jour 1 — matin	Fondamentaux de Planification IA des lits et des effectifs : concepts clés et vocabulaire · Pourquoi Planification IA d…	215
Jour 1 — après-midi	Méthodes et outils de Planification IA des lits et des effectifs · Exemple commenté du secteur Établissements de santé …	215
Jour 2 — matin	Gouvernance, risques et exigences ISO 7101 · Données, qualité et preuves à conserver · Quiz — scénarios de conformité e…	205
Jour 2 — après-midi	Déployer Planification IA des lits et des effectifs : rôles, changement et adoption · Indicateurs pour mesurer les résu…	205
Jour 3 — matin	Transfert en situation de travail : le plan 30-60-90 jours · Évaluation finale (niveau 2 de Kirkpatrick) · Atelier — pl…	180

Personas : Sponsor exécutif — Directeur général · Manager — directeur, responsable, pilote de processus · Membre de l'équipe — Soins cliniques et infirmiers

FICHE DE FORMATION

TR-AI-04 — Littératie en IA pour tous

Niveau Fondamentaux · 1.5 jour(s) · programme PRG-2 · 3 demi-journées, 11 activités, 10 h

Objectifs pédagogiques

• Expliquer les concepts clés de Littératie en IA pour tous et leur application à Soins cliniques et infirmiers
• Appliquer les méthodes et outils de Littératie en IA pour tous à un cas réel de Centre Hospitalier Régional
• Planifier le déploiement de Littératie en IA pour tous avec ses indicateurs et contrôles (ISO 7101)

Prérequis et types d'activités

Aucun — ouvert à tous
Lecture: 5 · Quiz: 3 · Workshop: 3

Déroulé par demi-journée

Demi-journée	Activités	min
Jour 1 — matin	Fondamentaux de Littératie en IA pour tous : concepts clés et vocabulaire · Pourquoi Littératie en IA pour tous compte …	215
Jour 1 — après-midi	Méthodes et outils de Littératie en IA pour tous · Exemple commenté du secteur Établissements de santé · Quiz — choisir…	215
Jour 2 — matin	Transfert en situation de travail : le plan 30-60-90 jours · Évaluation finale (niveau 2 de Kirkpatrick) · Atelier — pl…	180

Personas : Sponsor exécutif — Directeur général · Manager — directeur, responsable, pilote de processus · Membre de l'équipe — Soins cliniques et infirmiers

FICHE DE FORMATION

TR-AI-05 — Prompting et IA générative au travail

Niveau Fondamentaux · 1 jour(s) · programme PRG-2 · 2 demi-journées, 7 activités, 7 h

Objectifs pédagogiques

• Expliquer les concepts clés de Prompting et IA générative au travail et leur application à Soins cliniques et infirmiers
• Appliquer les méthodes et outils de Prompting et IA générative au travail à un cas réel de Centre Hospitalier Régional
• Planifier le déploiement de Prompting et IA générative au travail avec ses indicateurs et contrôles (ISO 7101)

Prérequis et types d'activités

Aucun — ouvert à tous
Lecture: 3 · Quiz: 2 · Workshop: 2

Déroulé par demi-journée

Demi-journée	Activités	min
Jour 1 — matin	Fondamentaux de Prompting et IA générative au travail : concepts clés et vocabulaire · Pourquoi Prompting et IA générat…	215
Jour 1 — après-midi	Transfert en situation de travail : le plan 30-60-90 jours · Évaluation finale (niveau 2 de Kirkpatrick) · Atelier — pl…	180

Personas : Sponsor exécutif — Directeur général · Manager — directeur, responsable, pilote de processus · Membre de l'équipe — Soins cliniques et infirmiers

FICHE DE FORMATION

TR-AI-06 — IA responsable et protection des données

Niveau Intermédiaire · 2 jour(s) · programme PRG-2 · 4 demi-journées, 15 activités, 14 h

Objectifs pédagogiques

• Expliquer les concepts clés de IA responsable et protection des données et leur application à Soins cliniques et infirmiers
• Appliquer les méthodes et outils de IA responsable et protection des données à un cas réel de Centre Hospitalier Régional
• Planifier le déploiement de IA responsable et protection des données avec ses indicateurs et contrôles (ISO 7101)

Prérequis et types d’activités

Culture numérique de base ; la formation Fondamentaux est recommandée
Lecture: 7 · Quiz: 4 · Workshop: 4

Déroulé par demi-journée

Demi-journée	Activités	min
Jour 1 — matin	Fondamentaux de IA responsable et protection des données : concepts clés et vocabulaire · Pourquoi IA responsable et pr…	215
Jour 1 — après-midi	Méthodes et outils de IA responsable et protection des données · Exemple commenté du secteur Établissements de santé · …	215
Jour 2 — matin	Gouvernance, risques et exigences ISO 7101 · Données, qualité et preuves à conserver · Quiz — scénarios de conformité e…	205
Jour 2 — après-midi	Transfert en situation de travail : le plan 30-60-90 jours · Évaluation finale (niveau 2 de Kirkpatrick) · Atelier — pl…	180

Personas : Sponsor exécutif — Directeur général · Manager — directeur, responsable, pilote de processus · Membre de l’équipe — Soins cliniques et infirmiers

Parcours, modules et ressources pédagogiques

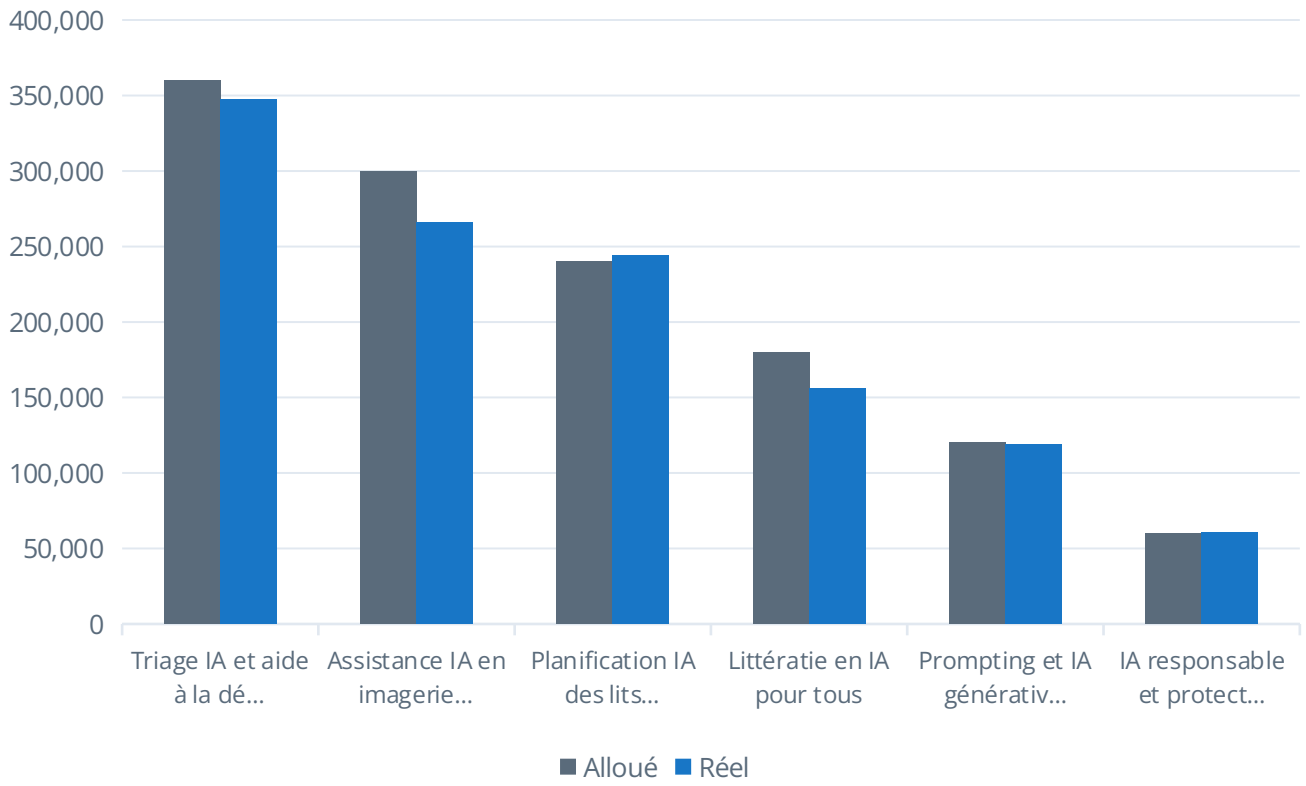
Parcours	Jours	Module	Modalité	Heures	Conception
Triage IA et aide à la décision clinique	3	M1 Triage IA et aide à la décision clinique	E-learning	2	Approuvé
		M3 Triage IA et aide à la décision clinique	Classe virtuelle	3.5	Approuvé
Assistance IA en imagerie médicale	2	M2 Assistance IA en imagerie médicale	Présentiel	7	Approuvé
		M4 Assistance IA en imagerie médicale	Présentiel	7	Approuvé

Ressource	Format	Taille (Mo)	Date de revue	Statut	Langue
Support M1	SCORM	42	2027-08-03	Publié	EN
Support M2	Video	180	2027-04-05	Publié	FR
Support M3	PDF	3.2	2026-12-06	Publié	AR
Support M4	Capsule	12	2026-08-08	Publié	FR

Source : RIF sections 5.3 et 5.4.

Alloué, engagé, consommé et remboursements attendus

Alloué 1 260 000, engagé 1 260 000 (100 %), réalisé 1 192 662 (95 % du prévu) ; remboursements attendus 352 800.



Alloué (gris) et réel (azur) par formation (RIF 5.7).

Ligne	Réel	Rembours.
Triage IA et aide à la décisi…	347 127	100 800
Assistance IA en imagerie méd…	266 091	84 000
Planification IA des lits et …	243 800	67 200
Littératie en IA pour tous	156 192	50 400
Prompting et IA générative au…	118 913	33 600
IA responsable et protection …	60 539	16 800
Total	**1 192 662**	352 800

Prestataire	Agrément jusqu'au	/5
Atlas Formation Conseil	2027-04-25	4.2
Maghreb Learning Partners	2027-08-03	3.8

05

Déploiement, évaluation et audit

Sessions, niveaux de Kirkpatrick, ROI, audit interne et retours d’expérience

AI Value
Digital & AI Transformation

Quatre sessions réalisées avec leurs inscriptions

Session	Date	Capacité	Formateur	Inscrits
S-01 Triage IA et aide à la décision clin…	2026-07-19	12	Rachid Benjelloun	3
S-02 Assistance IA en imagerie médicale	2026-07-26	12	Rachid Benjelloun	3
S-03 Triage IA et aide à la décision clin…	2026-08-02	12	Rachid Benjelloun	3
S-04 Assistance IA en imagerie médicale	2026-08-09	12	Rachid Benjelloun	3

10 / 12

apprenants présents à leur session

10 / 12

inscriptions achevées



Une tâche du processus de déploiement avec ses étapes typées.

ÉVALUATION

Résultats mesurés sur trois niveaux de Kirkpatrick

86 %

1 — Réaction

93 %

2 — Apprentissage

84 %

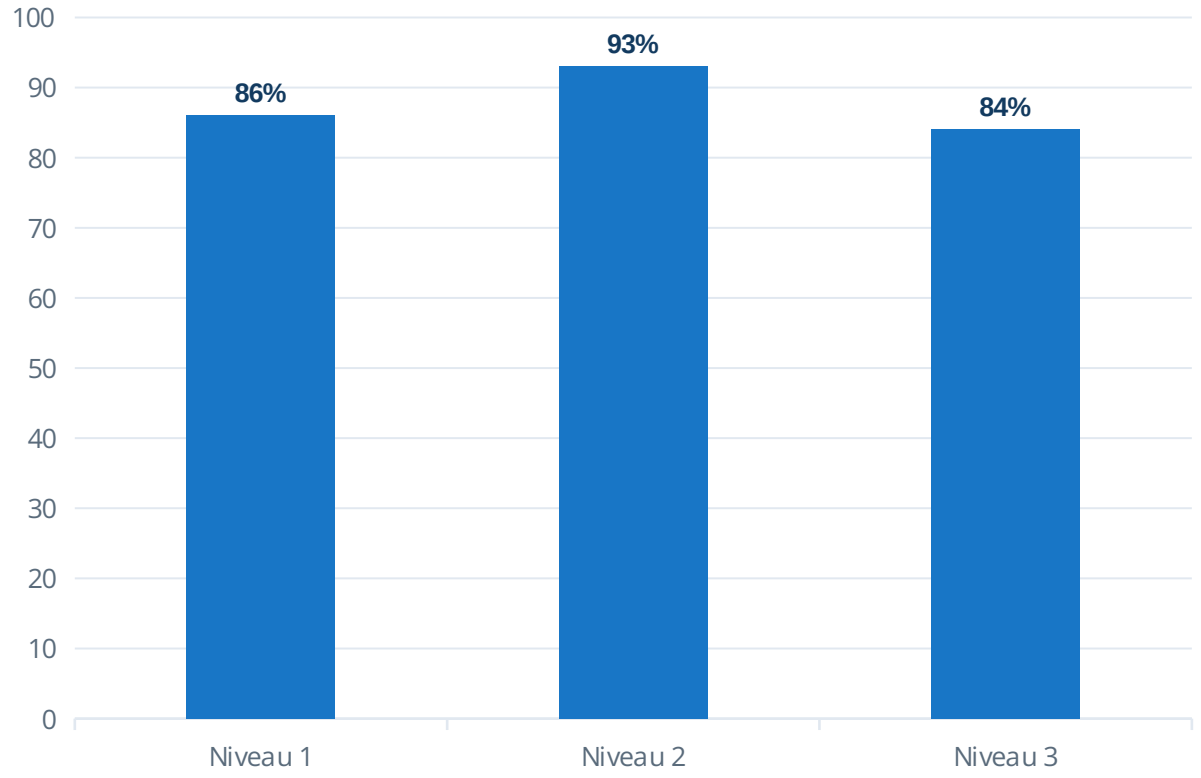
3 — Comportement

Niveau	Ce qui est mesuré	Quand	Instrument	Résultats
1 — Réaction	Satisfaction et utilité perçue	Fin de chaque session	Questionnaire de satisfaction	2 × 86 %
2 — Apprentissage	Connaissances et compétences acquises	Fin de la formation	Test avant/après, étude de cas	2 × 93 %
3 — Comportement	Mise en œuvre au poste de travail	Trois mois après	Grille d’observation du manager	2 × 84 %
4 — Résultats	Effet sur les indicateurs de la fonction	Six à douze mois après	Indicateurs de la fonction (KPI)	—

Certifications (RIF 5.10) : 4 valides, 1 à échéance proche, 1 expirée — l’expirée déclenche une alerte et une session de renouvellement.

Chaque évaluation enregistrée avec son score

6 évaluations reliées aux inscriptions des sessions (E2E-07)



Évaluation	Niveau	Score
Kirkpatrick niveau 1	1	93 %
Kirkpatrick niveau 1	1	79 %
Kirkpatrick niveau 2	2	93 %
Kirkpatrick niveau 2	2	92 %
Kirkpatrick niveau 3	3	76 %
Kirkpatrick niveau 3	3	92 %

Score moyen par niveau de Kirkpatrick.

Certifications suivies, renouvellements planifiés avant échéance

Exigences réglementaires et d’accréditation par agent (E2E-09)

4
certifications valides

1
à échéance sous 90 jours : session de renouvellement planifiée

1
expirée(s) : alerte envoyée au manager

Certification	Exigence	Valide jusqu’au	Statut
Sensibilisation ISO 7101	ISO 7101	2026-08-18	Valide
Sensibilisation ISO 7101	ISO 7101	2026-11-16	Expirée
Sensibilisation ISO 7101	ISO 7101	2027-02-14	Valide
Sensibilisation ISO 7101	ISO 7101	2027-05-15	Expire bientôt
Sensibilisation ISO 7101	ISO 7101	2027-08-13	Valide
Sensibilisation ISO 7101	ISO 7101	2027-11-11	Valide

ROI de Phillips et indicateurs de l’étude ROI

Rapport de ROI et d’impact métier — Centre Hospitalier Régional

108
ROI de la formation

4.5
Satisfaction moyenne de niveau 1

75.6
Taux de progression des compétences

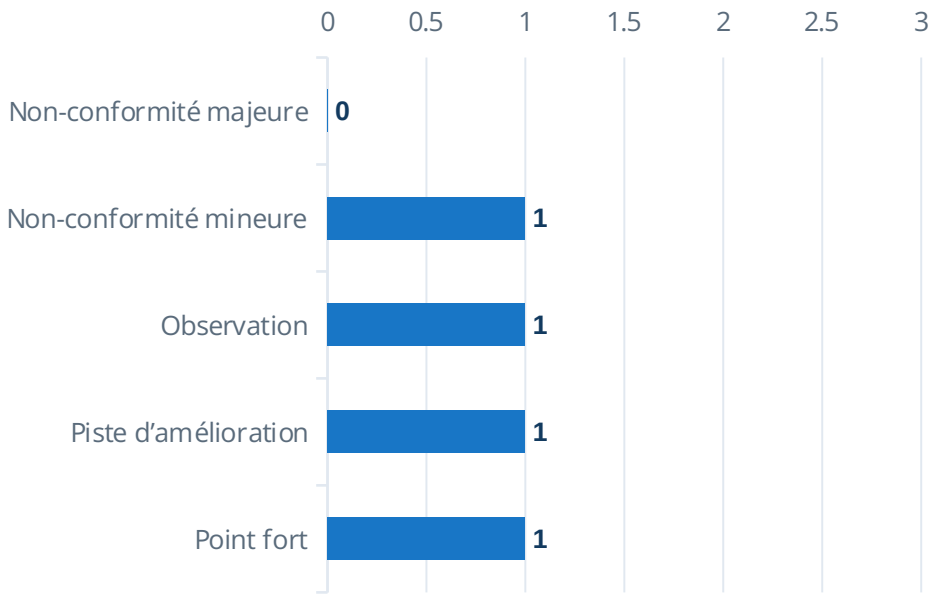
4.1
Écart d'exécution budgétaire

ID	Indicateur	Formule	Cible	Dernière valeur	Statut
KPI-037	ROI de la formation	(Bénéfices nets du programme / coûts du programme) x 100 (Phillips)	≥ 100 %	108 (2026-10)	Vert
KPI-012	Satisfaction moyenne de niveau 1	Score moyen de réaction sur les sessions clôturées (1-5)	≥ 4,2	4.5 (2026-10)	Vert
KPI-013	Taux de progression des compétences	Apprenants gagnant au moins un niveau en 6 mois / apprenants formés x...	≥ 70 %	75.6 (2026-10)	Vert
KPI-022	Écart d'exécution budgétaire	|Réel - alloué| / alloué x 100	≤ 5 %	4.1 (2026-10)	Vert
KPI-023	Taux de recouvrement des remboursements OFPPT	Remboursements reçus / remboursements prévus x 100	≥ 90 %	97.2 (2026-10)	Vert

Source : rapport ROI et impact métier (DT-E2E-08), section indicateurs.

Rapport d’audit — Centre Hospitalier Régional

Conforme avec une non-conformité mineure à corriger sous 60 jours.



ID	Niveau	Exigence	Constat
F-1	Non-conformité mineure	ISO 7101 7.2	Deux formateurs n’ont pas de preuve de compétence au dossier.
F-2	Observation	ISO 7101 9.1	Les évaluations de niveau 3 sont prévues mais pas encore planifiées.
F-3	Piste d’amélioration	ISO 7101 7.1.6	Capitaliser les retours d’expérience à la fin de chaque session.
F-4	Point fort	ISO 7101 7.2	Analyse des besoins entièrement tracée depuis les objectifs stratégiques.

Constats par niveau.

Points forts: Analyse des besoins claire ; forte implication du management ; feuilles de présence complètes.
Suivi: Vérification de l’action corrective au prochain comité de pilotage.

PLAN D’ACTIONS

Des actions correctives portées, datées et évaluées

Actions issues de l’audit et des indicateurs, chacune avec un porteur et un évaluateur (gouvernance)

Action	Échéance	Statut
Mettre à jour 11 fiches de poste obsolètes	2026-07-09	Ouverte
Contractualiser un second prestataire de formation	2026-06-09	Terminée

Comment les actions sont gouvernées

Un porteur réalise l’action, une autre personne en évalue l’efficacité.

Une action en retard déclenche une alerte au porteur et au chef de projet.

La clôture exige l’évaluation : le constat d’audit n’est clos qu’ensuite.

REX — Triage IA et aide à la décision clinique

Ce qui a bien fonctionné

Le registre des parties prenantes et la diffusion multicanale ont fait progresser le taux de réponse.

Ce qui n'a pas fonctionné

Les éléments SWOT d'une fonction sont arrivés en retard.

Cause racine

Aucun suppléant désigné pour le responsable de fonction.

Ce que nous ferons la prochaine fois

Désigner un suppléant pour chaque responsable de fonction dès le lancement.

06

Documents produits

37 documents publiés en français, chacun relié à ses données

AI Value
Digital & AI Transformation

Chaque processus de bout en bout laisse son document

Tous publiés, versionnés et approuvés par une seconde personne — 1 105 pages.

Code	Document	Pages
DT-E2E-01	Plan annuel de formation et budget	29
DT-E2E-02	Diagnostic des écarts de compétences	24
DT-E2E-03	Rapport des besoins de formation et feuille de route	30
DT-E2E-04	Dossier de conception pédagogique	26
DT-E2E-05	Rapport de réalisation des formations	30
DT-E2E-06	Rapport d'engagement des apprenants	30
DT-E2E-07	Rapport d'évaluation des formations	24
DT-E2E-08	Rapport de ROI et d'impact métier	24
DT-E2E-09	Registre de conformité et des certifications	23
DT-E2E-10	Mobilité interne et parcours de carrière	26

Code	Document	Pages
DT-E2E-11	Dossier du programme d'intégration	22
DT-E2E-12	Capitalisation et transfert des connaissances	23
DT-E2E-13	Catalogue et cycle de vie des contenus	24
DT-E2E-14	Rapport de formation de l'entreprise étendue	23
DT-E2E-15	Gouvernance des données, de l'IA et des intégrations	24
DT-E2E-16	Dossier de gestion des prestataires	22
DT-E2E-17	Plan de conduite du changement et d'adoption	23
DT-E2E-18	Rapport qualité, risques et amélioration	31
DT-E2E-19	Rapport de clôture de mission de conseil	26
DT-E2E-20	Rapport de diagnostic multi-axes et de maturité	27

Documents produits (suite)

Code	Document	Pages
DT-E2E-21	Évaluation de l'impact du plan précédent	26
DT-E2E-22	Plan de déploiement multi-sites	24
DT-E2E-23	Dossier de soumission réglementaire	22
DT-E2E-24	Note de veille concurrentielle	23
DT-E2E-25	Architecture des emplois et cartographie des compétences	23
DT-E2E-26	Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC)	25
DT-E2E-27	Consolidation des demandes de formation	22
DT-E2E-28	Évaluation des performances et tableau RAG	22
DT-E2E-29	SWOT fonctionnel et axes d'amélioration	23
DT-E2E-30	Plan de ressources priorisé	25

Code	Document	Pages
DT-E2E-31	Feuille de route post-mission	24
DT-E2E-32	Cahier des charges et registre des parties prenantes	33
DT-E2E-33	Rapport de campagne de questionnaires	30
DT-TER	Rapport d'ingénierie de formation et plan de formation	210
DT-PLAN	Plan de formation avec programmes détaillés	36
DT-AUDIT	Rapport d'audit	5
DT-MASTER	Liste maîtresse des informations documentées	21

Comment les équipes ont saisi et gouverné les données

CortexSkills 1.11 — SRS Standard Application v1.8

Formulaires d'étape typés

Chaque étape demande ce qu'elle produit : enregistrements, matrices, décisions ; chaque ligne est enregistrée, avec annulation.

Saisie plein écran

Tout tableau s'ouvre en plein écran avec zoom (50–200 %), ajout, enregistrement et retour à la même ligne.

Coller depuis Excel ou Word

Les listes d'agents ou de formations se collent en une fois, vérifiées cellule par cellule, enregistrées et annulables en une opération.

Montants avec leur devise

Les budgets portent leur devise ; un total ne mélange jamais des devises sans taux et date indiqués.

Publication à deux personnes

Un document n'est publié qu'après l'approbation d'une seconde personne ; chaque version est conservée.

Piste d'audit

Chaque modification, collage et approbation est enregistré avec son auteur, sa date et sa justification.

TRAÇABILITÉ

Chaque chiffre du rapport provient d’un enregistrement

Chaque tableau de ce document provient des enregistrements de l’application ; données au 07/10/2026 15:28:07.

Source	Enreg.	Processus	Dernière modif.
Réponses aux questionnaires	32	MP-54	—
Stakeholder	40	MP-53	2026-10-07
ScopeCriterion	17	MP-52	2026-10-07
SkillAssessment	12	MP-16	2026-10-07
SkillGap	8	MP-16	2026-10-07
TrainingNeed	10	MP-03	2026-10-07
RoadmapInitiative	4	MP-04	2026-10-07
WbsNode	3	MP-49	2026-10-07
Session	4	MP-05	2026-10-07
TrainingPlan	1	MP-49	2026-10-07
Employee	16	MP-16	2026-10-07
StrategicObjective	2	MP-01	2026-10-07

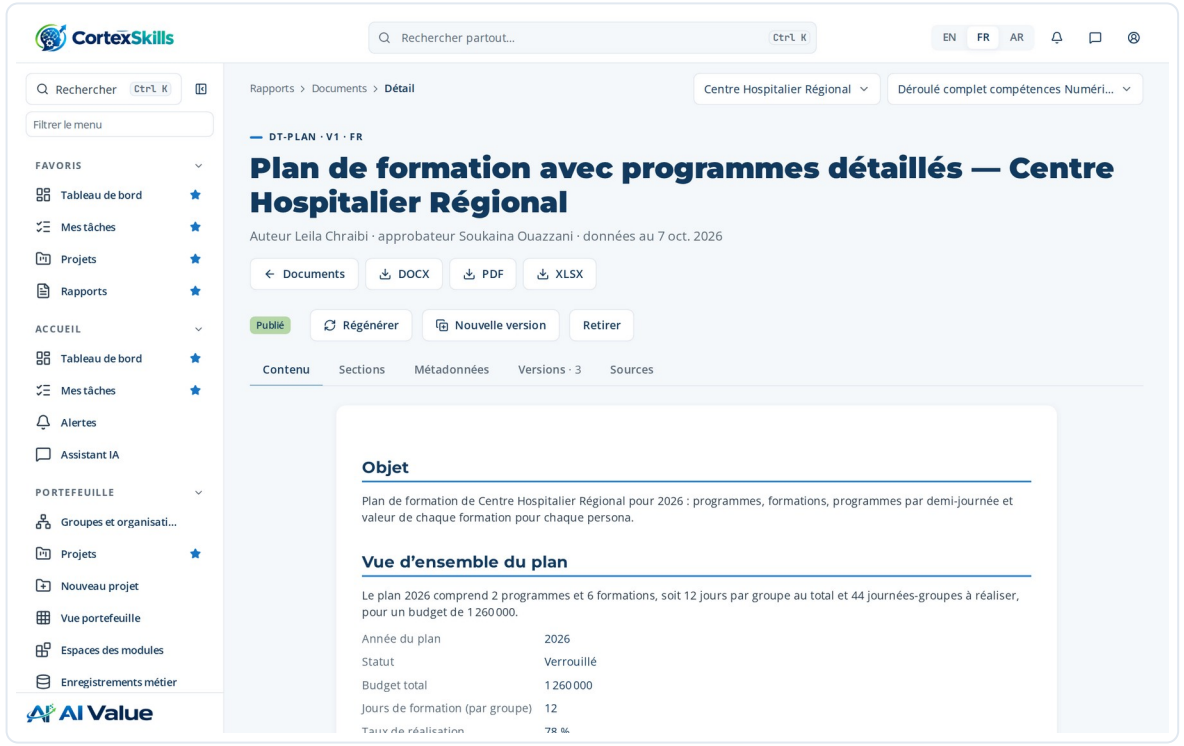
Gouvernance des documents

Auteur Leila Chraibi, approbateur Soukaina Ouazzani : deux personnes différentes.

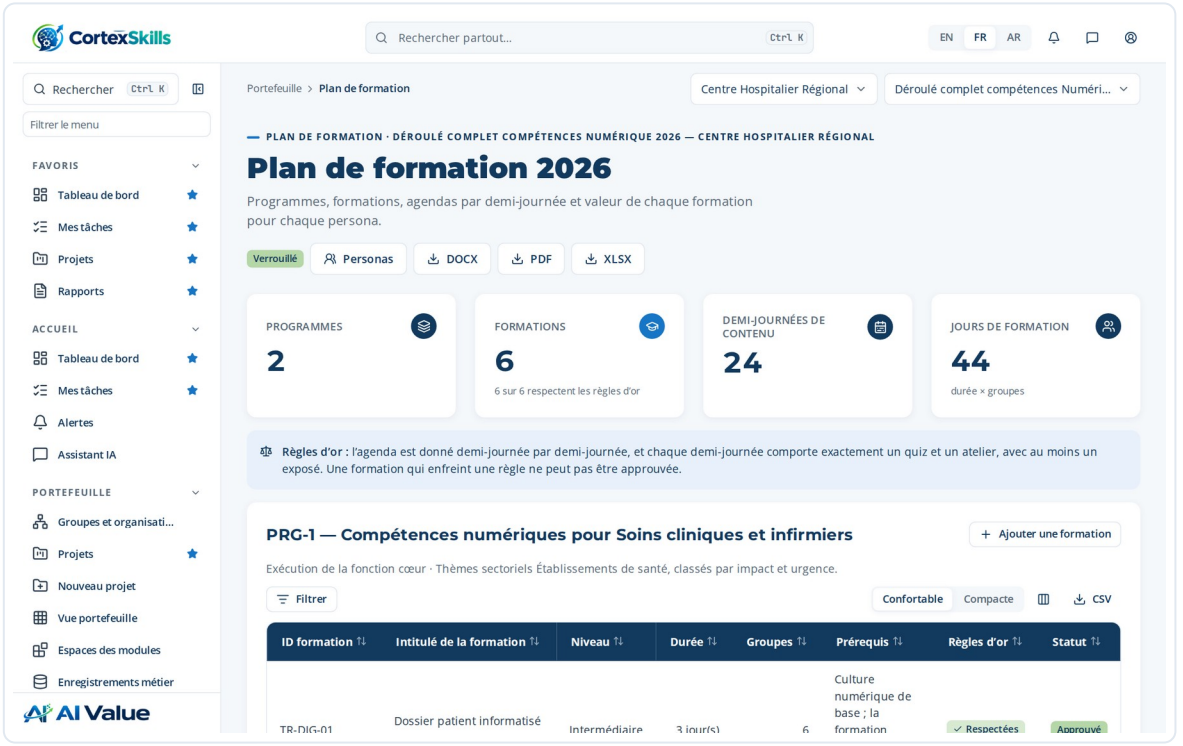
Chaque version est conservée ; un changement des données marque le document comme obsolète.

20 sources de données listées avec leur nombre d’enregistrements et leur processus.

Le plan de formation tel que les utilisateurs le voient

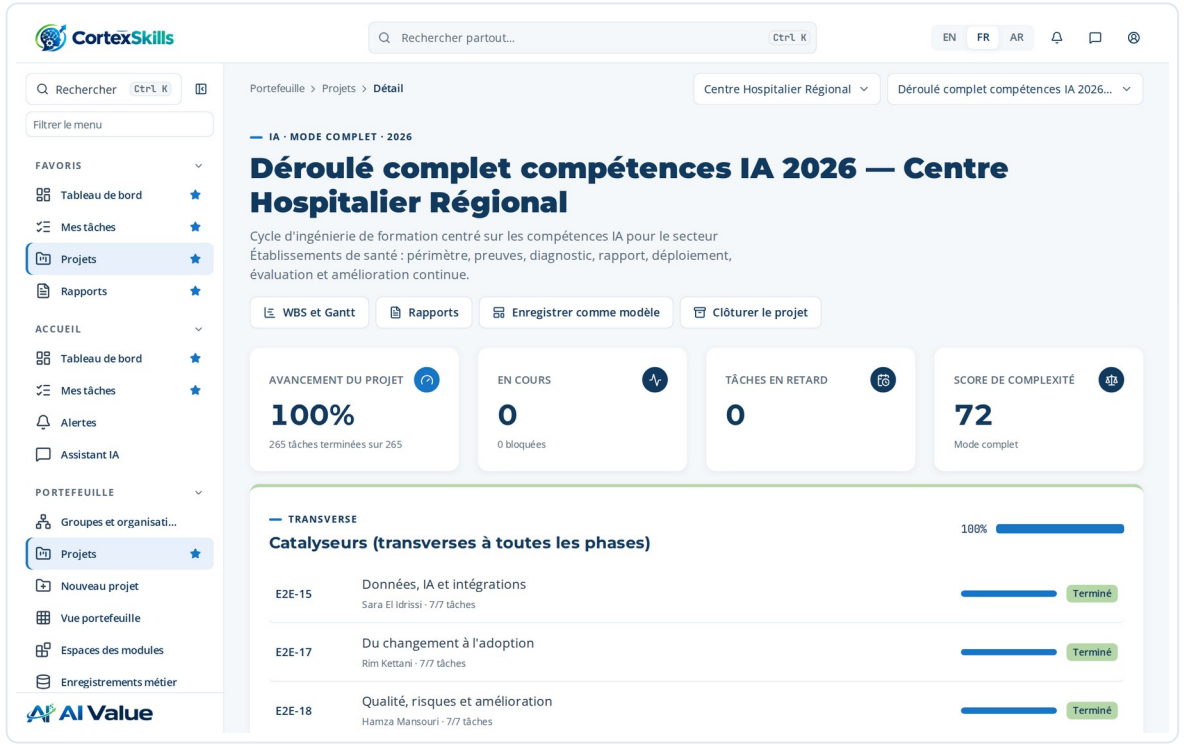


Plan de formation avec programmes détaillés — Centre Hospitalier Régional



Écran du plan de formation : programmes, formations et sessions.

L'espace projet et le tableau de bord



Espace projet : phases, processus et avancement.

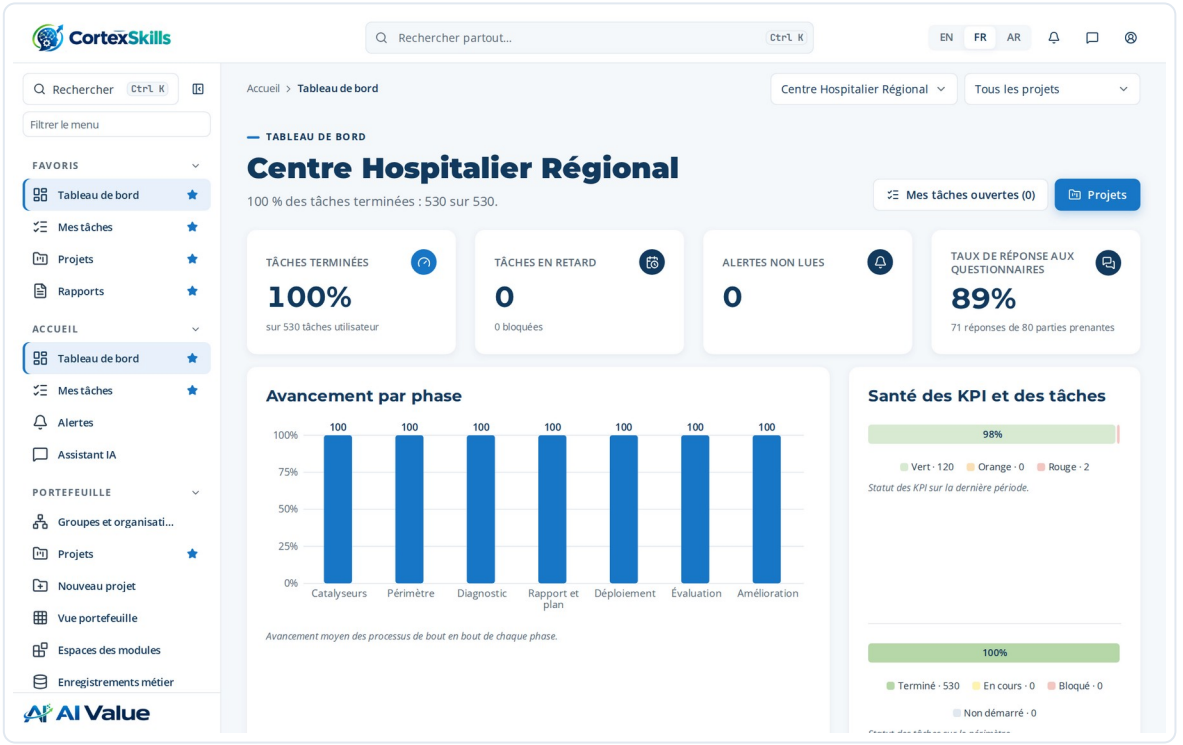


Tableau de bord de l'hôpital.

Ce que l’hôpital obtient en fin de cycle

- Un Rapport d’ingénierie de formation de 210 pages, construit à partir de 37 réponses, 40 parties prenantes et du diagnostic de chaque fonction.
- Un Plan de formation verrouillé : 6 formations, des déroulés par demi-journée, une proposition de valeur par persona et un budget de 1 260 000
- Une évaluation sur trois niveaux de Kirkpatrick, une étude ROI, des certifications suivies et un audit interne avec une non-conformité mineure à corriger.
- 37 documents publiés, prêts pour un audit d’accréditation (ISO 7101, JCI), chacun relié aux données et à l’étape qui l’a produit.
- Ensuite : vagues 2 et 3 de la feuille de route et évaluation de niveau 4 (résultats) six à douze mois après les formations.

AI Value

Digital & AI Transformation

MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

Merci

MEASURABLE · GOVERNED · SUSTAINABLE